AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

Repaso de última hora

PSIQUIATRÍA GENERAL

20 temas · 1 página cada uno

Salud Mental

8 temas ★★★ según preguntas reales 2013–2025 · plan de repaso de 7 días

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Trastornos del Ánimo & Urgencias Suicidas

★★★ 17.1. Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES GES 3
★★☆ 17.2. Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES GES 5
★☆☆ 17.3. Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización 7
★★★ 17.4. Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal GES 8
★★★ 17.5. Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo GES 9

02 Trastornos de Ansiedad, TOC & Trauma

★★★ 17.6. Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS 10
★★☆ 17.7. Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social 11
★★☆ 17.8. Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS 12
★★☆ 17.9. Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo 13

03 Trastornos Psicóticos & Urgencias Psiquiátricas

★★★ 17.10. Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES GES 14
★★★ 17.11. Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma GES 16
★★★ 17.12. Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve GES 17
★☆☆ 17.13. Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo 18
★☆☆ 17.14. Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada 20
★☆☆ 17.19. Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense 21

04 Adicciones, Personalidad & Salud Mental Infanto-Juvenil

★★☆ 17.15. Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke GES 22
★★☆ 17.16. Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) GES 24
★☆☆ 17.17. Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C 25
★★★ 17.18. Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria 26
★☆☆ 17.20. Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad 27

Números que tienes que saber 28
Fármacos de primera línea 30
GES de la especialidad 30
Plan de repaso de 7 días 32
Índice por prioridad ★ 33

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS TIER 3

17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

Máxima rentabilidad · Patología de salud mental más preguntada en el EUNACOM

★★★ PRIORIDAD ALTA
25 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 21): Depresión en personas de 15 años y más · Sospecha con confirmación diagnóstica en ≤ 24 horas en Atención Primaria de Salud (APS), inicio inmediato de psicoterapia y farmacoterapia (ISRS de 1.ª línea), y control clínico presencial a las 2 semanas.

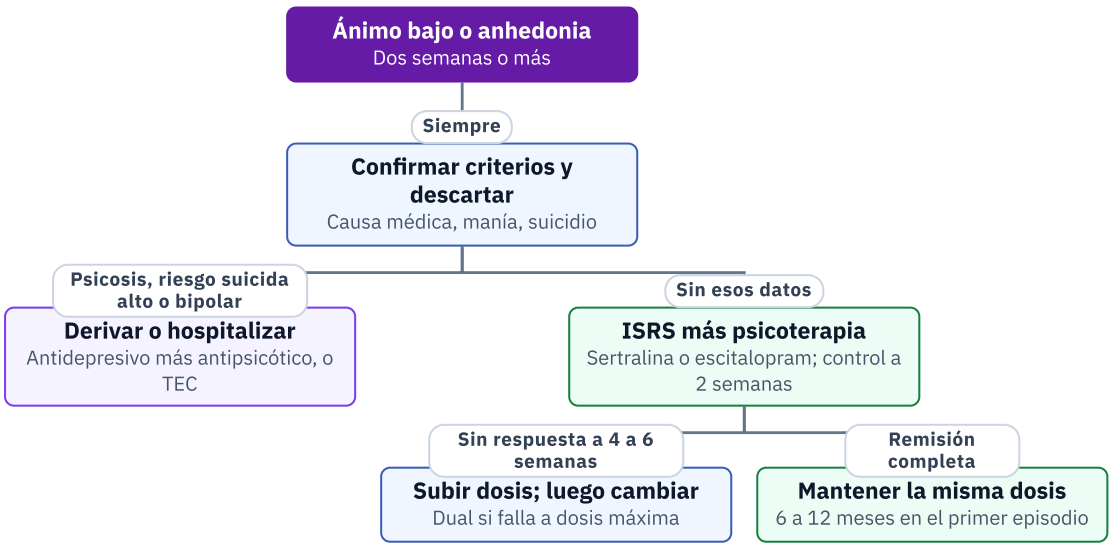
5.01.1.007	Primer episodio depresivo	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
5.01.1.008	Trastorno depresivo (recurrente)	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
5.01.1.034	Trastornos del ánimo en niños	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Completo
2.01.1.136 1.07.1.004	Depresión	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico de Trastorno Depresivo Mayor exige al menos 5 de 9 criterios DSM-5 por **≥ 2 semanas** consecutivas, con presencia obligatoria de ánimo deprimido o anhedonia.
- En Chile, el TDM en mayores de **15 años** está cubierto por GES N° 21: la confirmación diagnóstica e inicio terapéutico deben realizarse dentro de **24 horas** desde la sospecha.
- Los ISRS (Sertralina **50-100 mg**/día o Escitalopram **10-20 mg**/día) son la primera línea farmacológica de elección en atención primaria.
- **Latencia de acción**: los antidepresivos requieren entre 2 y **4 semanas** para alcanzar su efecto terapéutico; jamás suspender precozmente por aparente ineficacia en la primera semana.
- **Regla de oro de mantenimiento**: tras lograr la remisión clínica completa, el fármaco se debe mantener a la misma dosis durante **6 a 12 meses** para evitar recaídas.
- Sertralina es el antidepresivo más seguro en pacientes con cardiopatía isquémica reciente y de primera elección en la mujer durante la lactancia materna.
- Bupropión no produce disfunción sexual ni aumento de peso, pero está formalmente contraindicado en pacientes con epilepsia o antecedentes de bulimia/anorexia por riesgo de convulsiones.

ALGORITMO · DEPRESIÓN MAYOR: DE LA SOSPECHA AL MANTENIMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **3–17** (págs. 8–10) · solucionario págs. 22–24.

Clase 17.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

★★★ PRIORIDAD ALTA

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

TABLA 17.1 · CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DSM-5 Y CLASIFICACIÓN POR SUBTIPOS CLÍNICOS DE DEPRESIÓN

SUBTIPO CLÍNICO	CARACTERÍSTICAS CARDINALES	BIOMARCADORES / CLÍNICA CLAVE	FÁRMACO PREFERENCIAL
Depresión Típica / Mayor	≥ 5 de 9 criterios por ≥ 2 semanas con ánimo bajo o anhedonia	Insomnio de conciliación/intermedio, anorexia, astenia, culpa	ISRS (Sertralina 50-100 mg, Escitalopram 10-20 mg)
Depresión Melancólica	Anhedonia completa, falta de reactividad afectiva, culpa patológica	Despertar precoz (> 2 h antes), peor en la mañana, baja de peso rápida	Duales (Venlafaxina), Tricíclicos (Amitriptilina) o TEC si severa
Depresión Atípica	Reactividad del ánimo positiva transitoria, sensibilidad al rechazo	Hipersomnia diurna, hiperfagia ("carbo craving"), parálisis de plomo	ISRS, Bupropión o IMAO en casos resistentes
Depresión Psicótica	Delirios de culpa, ruina, hipocondría extrema (Cotard) o alucinaciones	Emergencia psiquiátrica · Riesgo suicida extremo · Catatonía	ISRS/IRSN + Antipsicótico atípico (Olanzapina/Quetiapina) o TEC
Depresión Estacional (SAD)	Episodios recurrentes en otoño/invierno con remisión en primavera	Hipersomnia, aumento de peso, relación con privación de luz solar	Fototerapia matinal (10.000 lux) + ISRS (Fluoxetina/Bupropión)

TRAMPAS EUNACOM clase psiq-01

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Depresión sin psicosis ni riesgo	ISRS y psicoterapia	Benzodiacepina sola
Mejoría parcial, buena tolerancia	Subir la dosis	Cambiar de familia de entrada
ISRS a dosis máxima sin respuesta	Cambiar a dual	Seguir igual más tiempo
Remisión completa	Mantener 6 a 12 meses	Suspender al mejorar

REGLA DE ORO **5 de 9 por 2 semanas** — Ánimo bajo o anhedonia obligatorio

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El trastorno depresivo mayor (TDM) es la principal causa de discapacidad por enfermedad mental a nivel global y un problema de salud pública prioritario en Chile garantizado por GES N° 21. La depresión no es una debilidad del carácter ni un duelo prolongado, sino una alteración neurobiológica con disminución de neurotransmisores monoaminérgicos (serotonina, noradrenalina, dopamina) y disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal con atrofia del hipocampo. El médico general debe dominar el diagnóstico clínico preciso, descartar organicidad y trastorno bipolar, iniciar ISRS a dosis adecuadas advirtiendo el período de latencia y sostener el tratamiento de mantenimiento para evitar recaídas.

TABLA 17.1.B · FARMACOLOGÍA ANTIDEPRESIVA DE PRIMERA Y SEGUNDA LÍNEA: DOSIS, EFECTOS Y PRECAUCIONES

FÁRMACO / FAMILIA	MECANISMO DE ACCIÓN	DOSIS HABITUAL / VÍA	EFECTOS ADVERSOS Y PERLAS CRÍTICAS
Sertralina (ISRS)	Inhibición selectiva recaptación 5-HT	50 – 200 mg/día VO (mañana)	Seguro en cardiopatía isquémica y lactancia · Molestias GI transitorias al inicio
Escitalopram (ISRS)	Inhibición selectiva pura de 5-HT	10 – 20 mg/día VO (mañana)	Menores interacciones farmacológicas · Precaución prolongación QTc en dosis > 20 mg
Fluoxetina (ISRS)	Inhibición recaptación 5-HT + 5-HT2c	20 – 60 mg/día VO (mañana)	Leve efecto estimulante · Vida media larga (disminuye síndrome de discontinuación)
Venlafaxina (IRSN)	Inhibición dual 5-HT y NA (a dosis > 150 mg)	75 – 225 mg/día VO (con comida)	Eficaz en dolor neuropático y melancolía · Monitorizar presión arterial sistémica
Bupropión (IRND)	Inhibición recaptación NA y DA	150 – 300 mg/día VO (mañana)	Sin disfunción sexual ni ganancia de peso · Útil para cesación tabáquica · Prohibido en epilepsia/TCA
Mirtazapina (NaSSA)	Antagonista alfa-2 presináptico y 5-HT2/3	15 – 45 mg/día VO (noche)	Sedación e incremento marcado de apetito · Excelente en ancianos con insomnio y baja de peso

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **3–17** (págs. 8–10) · solucionario págs. 22–24.

Clase 17.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS TIER 3

17.2 Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

Alta · Diagnóstico diferencial crítico de depresión recurrente y urgencias afectivas

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 52): Trastorno Bipolar en personas de 15 años y más · Confirmación diagnóstica por médico especialista en psiquiatría en ≤ 60 días desde la sospecha, inicio inmediato de tratamiento farmacológico estabilizador del ánimo y hospitalización de urgencia protegida en episodio maníaco agudo.

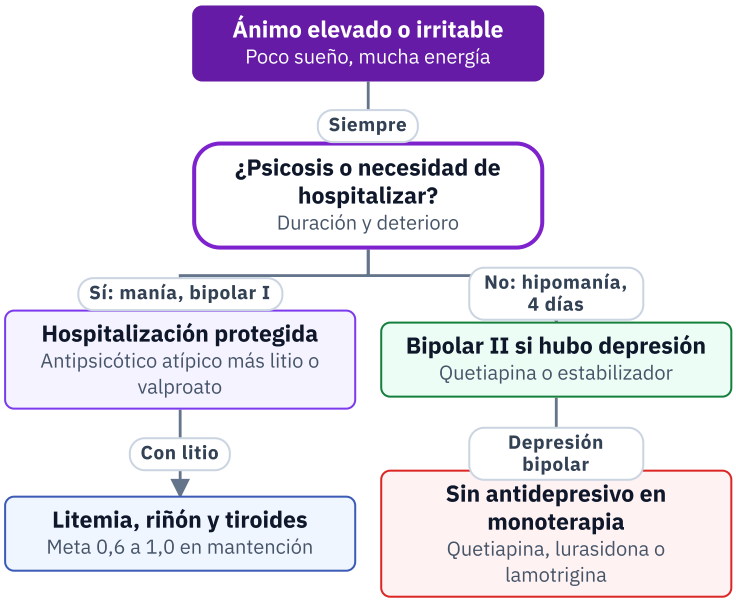
5.01.1.009	Trastorno bipolar	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
5.01.4.003	Niveles plasmáticos de estabilizadores del ánimo	Interpreta y emplea	

LO QUE TE PREGUNTAN

- Un solo episodio maníaco a lo largo de la vida es suficiente para diagnosticar Trastorno Bipolar Tipo I de forma definitiva.
- La hipomanía dura al menos **4 días**, no genera disfunción social/laboral grave y NUNCA cursa con síntomas psicóticos ni requiere hospitalización.
- Cualquier episodio expansivo que presente delirios o alucinaciones, o que requiera hospitalización, se clasifica automáticamente como MANÍA.
- El tratamiento de elección en manía aguda grave es la combinación de un antipsicótico atípico (Olanzapina, Risperidona, Quetiapina) con un estabilizador (Litio o Valproato).
- El Carbonato de Litio es el estándar de oro en prevención de recaídas y el único estabilizador con reducción demostrada del riesgo suicida.
- **Rango terapéutico de la litemia**: **0.6 a 1.0 mEq/L** en mantenimiento; se mide en sangre exactamente a las **12 horas** post-dosis.
- **Toxicidad por litio**: temblor grosero, ataxia y confusión con litemia > 1.5-2.0; hemodiálisis indicada si > **4.0 mEq/L** o > **2.5 mEq/L** con compromiso neurológico grave.

ALGORITMO · TRASTORNO BIPOLAR: DE LA ELEVACIÓN DEL ÁNIMO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 17.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.2 Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 17.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: MANÍA VS HIPOMANÍA VS EPISODIO MIXTO = TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE PSIQ-02

PARÁMETRO	EPISODIO MANÍACO (BIPOLAR I)	EPISODIO HIPOMANÍACO (BIPOLAR II)	EPISODIO MIXTO
Duración mínima	≥ 7 días consecutivos (o cualquier duración si se hospitaliza)	≥ 4 días consecutivos	Cumple criterios de manía/hipomanía + síntomas depresivos simultáneos
Disfunción funcional	Severa: incapacidad laboral, quiebra económica, problemas legales	Ausente o leve: funcionalidad social y laboral conservada	Severa con gran disforia, angustia e impulsividad
Síntomas psicóticos	Frecuentes (delirios megalomaníacos, místicos o auditivos)	ESTRICTAMENTE AUSENTES (su presencia = manía)	Pueden estar presentes (congruentes o incongruentes)
Criterio de hospitalización	Frecuentemente necesaria por riesgo físico o social	NUNCA requiere hospitalización (si requiere = manía)	Alta necesidad por riesgo suicida extremo
Diagnóstico resultante	Trastorno Bipolar Tipo I (un solo episodio lo define)	Trastorno Bipolar Tipo II (exige además depresión previa)	Especificador de Bipolar I o II según gravedad

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA clase psiq-02

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Psicosis o hospitalización	Manía, no hipomanía	Llamarlo hipomanía
Euforia tras iniciar ISRS	Suspender; es bipolar	Subir la dosis
Depresión en bipolar	Quetiapina o lamotrigina	ISRS solo
Litemia alta con temblor y ataxia	Suspender y suero fisiológico	Diurético o carbón
Bipolar que planea embarazo	Cambiar valproato antes	Mantener valproato

REGLA DE ORO **Un episodio maníaco: bipolar I** — Manía: 7 días, psicosis o deterioro

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El trastorno bipolar es una patología psiquiátrica crónica y recurrente caracterizada por fluctuaciones patológicas del estado de ánimo entre polos de exaltación (manía/hipomanía) y depresión profunda. Su base genética es la más alta entre los trastornos psiquiátricos mayores (heredabilidad ~80%). Un error frecuente y catastrófico en el examen y en la clínica es confundir una depresión bipolar con una depresión monopolar y prescribir antidepresivos en monoterapia, lo que induce viraje a manía severa, aceleración de ciclos o conductas suicidas. El pilar innegociable es el uso de estabilizadores del ánimo, siendo el litio el fármaco de referencia con demostrada capacidad antisuicida.

TABLA 17.2.B · ESQUEMAS TERAPÉUTICOS EN FASE MANÍACA, DEPRESIÓN BIPOLAR Y PROFILAXIS

ESCENARIO CLÍNICO	ESTRATEGIA DE PRIMERA LÍNEA	ALTERNATIVA TERAPÉUTICA	FÁRMACOS CONTRAINDICADOS / ERRORES
Manía Aguda Severa con Psicosis	Antipsicótico atípico (Olanzapina 10-20 mg o Risperidona 3-6 mg) + Litio o Valproato	Haloperidol 5 mg IM/VO + Lorazepam (agitación aguda) o TEC si refractaria	Antidepresivos · Suspender inmediatamente si los tomaba
Manía Aguda Moderada	Monoterapia con Litio, Valproato o Quetiapina 400-800 mg/día	Aripiprazol 15-30 mg/día o Asenapina	Monoterapia con benzodiacepinas a largo plazo
Depresión Bipolar Aguda	Quetiapina 300 mg/día o Lurasidona 40-80 mg/día o Olanzapina-Fluoxetina	Lamotrigina (titulación lenta) o Cariprazina	ISRS o Duales en monoterapia (riesgo de viraje y suicidio)
Profilaxis y Mantenimiento	Carbonato de Litio (meta 0.6-0.8 mEq/L) como estándar de oro	Valproato sódico o Lamotrigina (si predominan depresiones)	Abandono de controles de litemia, creatinina y TSH semestrales

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, pregunta **18** (pág. 10) · solucionario pág. 24.

Clase 17.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS TIER 3

17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

5.01.2.001	Conducta suicida	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	5.01.3.002	Conducta suicida	Conocimiento general
5.01.5.003	Intervención en crisis	Realizar	5.01.1.029	Intento de suicidio en niños y adolescentes	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
2.01.1.137	Ideación suicida	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar			

LO QUE TE PREGUNTAN

- El antecedente de intento suicida previo es el factor de riesgo independiente más potente para suicidio consumado a largo plazo.
- Preguntar directamente y de forma empática sobre la presencia de ideas, planes y métodos suicidas es obligatorio y NO induce el suicidio.
- En Chile, los hombres se suicidan con una frecuencia **4 a 5 veces** mayor que las mujeres debido a la elección de métodos más letales (ahorcamiento, armas de fuego).
- **La escala SAD PERSONS orienta la gravedad clínica**: puntajes **≥ 7 puntos** indican riesgo severo y exigen hospitalización psiquiátrica inmediata.
- Todo paciente con intento suicida reciente o plan estructurado activo debe permanecer con acompañamiento visual 1 a 1 permanente.
- El Carbonato de Litio y la Clozapina son los únicos dos fármacos que han demostrado reducir la mortalidad por suicidio en ensayos clínicos controlados.

ALGORITMO · RIESGO SUICIDA: DE LA IDEACIÓN A LA DECISIÓN

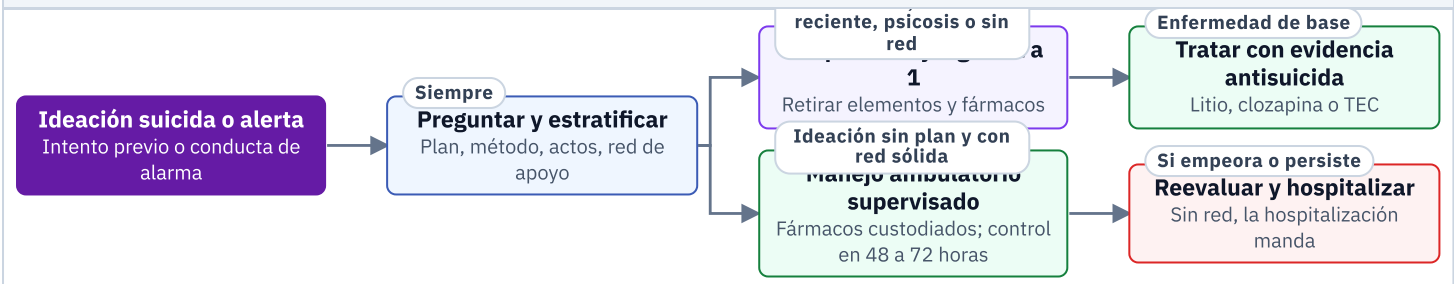


TABLA 17.3 · FACTORES DE RIESGO SUICIDA, DESENCADENANTES AGUDOS Y FACTORES PROTECTORES

CATEGORÍA	FACTORES DE ALTO RIESGO	SEÑALES DE ALARMA INMINENTE	FACTORES PROTECTORES FUERTES
Sociodemográficos	Hombres, > 65 años o 15-24 años, viudos, desempleados, aislamiento	Regalar posesiones queridas, cerrar cuentas bancarias, cartas de despedida	Hijos pequeños a cargo, red de apoyo extensa, empleo estable
Clínico-Psiquiátricos	Intento previo (factor N° 1), depresión melancólica, trastorno bipolar, adicciones	Desesperanza extrema, insomnio refractario, calma repentina sospechosa	Buena adherencia a tratamiento psiquiátrico, alianza terapéutica sólida
Psicopatológicos	Impulsividad alta, agitación, delirios de culpa/ruina, alucinaciones de comando	Declaración explícita de método con acceso a armas o pastillas	Creencias religiosas/morales firmes contrarias al suicidio
Biológicos / Médicos	Dolor crónico intratable, cáncer terminal, diagnóstico reciente de VIH o ELA	Intoxicación aguda por alcohol que desinhibe la barrera inhibitoria	Capacidad de resolución de problemas, proyectos futuros viables

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-03

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Sospecha de ideas suicidas	Preguntar directo	Evitar el tema
Intento previo	Riesgo alto de entrada	Minimizarlo por antiguo
Plan, método y carta de despedida	Hospitalizar, vigilar 1 a 1	Alta con familiar

REGLA DE ORO **Preguntar directo no induce** — Ideación, plan, método, actos

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, pregunta **2** (pág. 8) · solucionario pág. 22.

Clase 17.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.4 Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 21): Depresión en personas de 15 años y más · Tamizaje universal obligatorio con Escala de Edimburgo (EPDS) en controles de niño sano a los 2 y 6 meses en APS · Manejo con psicoterapia y fármacos compatibles con la lactancia.

5.01.1.007 Primer episodio depresivo — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- El "Baby blues" o tristeza posparto inicia en los primeros **3 a 5 días** y se resuelve espontáneamente antes de las **2 semanas** sin necesidad de fármacos.
- La Depresión Posparto se pesquisa universalmente en APS mediante la Escala de Edimburgo (EPDS); un puntaje **≥ 10 puntos** exige confirmación y manejo activo bajo GES N° 21.
- Sertralina es el antidepresivo de elección durante la lactancia materna por su baja excreción en leche y excelente perfil de seguridad en el lactante.
- Paroxetina es una alternativa segura en lactancia, mientras que Fluoxetina se evita como primera opción por su larga vida media y metabolitos activos.
- La Psicosis Puerperal es una emergencia psiquiátrica absoluta con riesgo inminente de infanticidio y suicidio que exige hospitalización inmediata y separación protegida supervisada.

ALGORITMO · PUÉRPERA CON CAMBIOS DEL ÁNIMO: DE LA SOSPECHA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

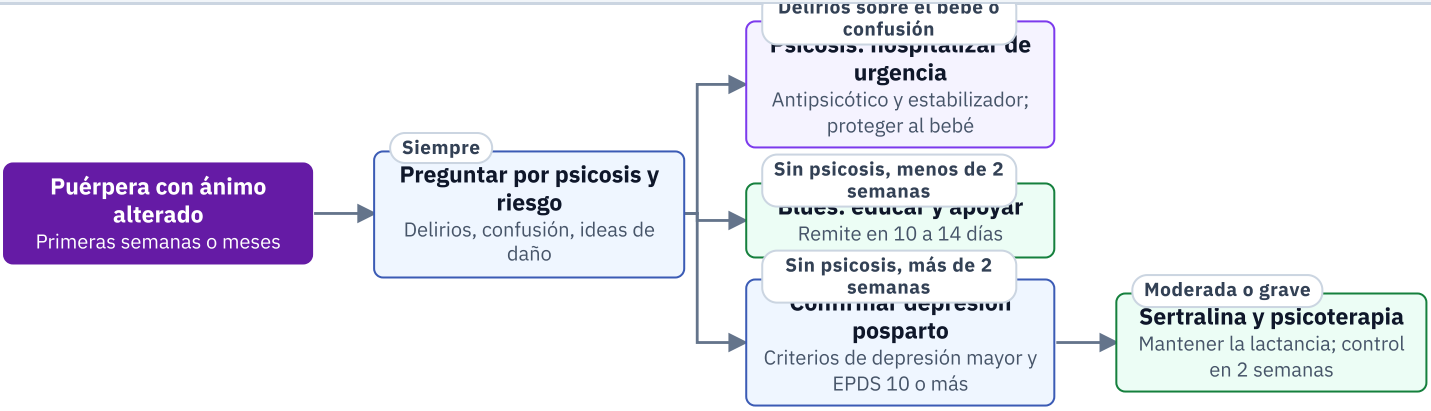


TABLA 17.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: DISFORIA PUERPERAL (BLUES) VS DEPRESIÓN POSPARTO VS PSICOSIS PUERPERAL

CARACTERÍSTICA	DISFORIA PUERPERAL ("BLUES")	DEPRESIÓN POSPARTO (DPP)	PSICOSIS PUERPERAL
Prevalencia	50 – 80% de las madres	10 – 15% de las madres	0.1 – 0.2% (1-2 por 1.000 partos)
Inicio temporal	Precoz: 3.º a 5.º día postparto	2.ª a 6.ª semana (hasta 1 año)	Hiperagudo: 3.º a 14.º día postparto
Clínica cardinal	Labilidad emocional, llanto, fatiga	Anhedonia, culpa, desapego, tristeza	Delirios sobre el bebé, confusión, alucinaciones
Vínculo con el bebé	Preservado y afectuoso	Dificultoso, ambivalente, culpa	Ruptura grave · RIESGO DE INFANTICIDIO
Evolución y manejo	Autolimitado (< 14 días) · Apoyo familiar	Persistente · ISRS (Sertralina) + TCC	EMERGENCIA MÉDICA · Hospitalización inmediata + TEC/Antipsicóticos

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-04

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Llanto fácil, día 5, vínculo bueno	Educar y apoyar	Dar antidepresivo
Anhedonia y culpa a las 6 semanas	Depresión posparto: tratar	Decir que es el blues

REGLA DE ORO **Blues: día 3 a 5; breve** — Vínculo preservado; sin fármacos

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Psiquiatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 17.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS

17.5 Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

GES GES N° 21 en caso de sobreimposición de episodio depresivo mayor ("depresión doble") · Manejo en APS con psicoterapia de apoyo y resolución de estresores psicosociales.

5.01.1.004	Trastorno de adaptación	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo	5.01.1.020	Trastornos somatomorfos	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Trastorno Adaptativo inicia dentro de los **3 meses** posteriores a un estresor biográfico identificable y se resuelve en menos de **6 meses** tras el fin del estresor.
- Los síntomas del Trastorno Adaptativo no alcanzan el umbral diagnóstico de 5 criterios de un Episodio Depresivo Mayor.
- El tratamiento de elección del Trastorno Adaptativo es la psicoterapia breve; los psicofármacos NO son la primera línea y no deben indicarse rutinariamente.
- La Distimia (Trastorno Depresivo Persistente) exige al menos **2 años** de ánimo depresivo continuo en adultos (al menos 1 año en niños y adolescentes).
- En la distimia, el paciente no permanece más de **2 meses** consecutivos sin síntomas durante el período de **2 años**.
- Depresión doble es la concurrencia de un Episodio Depresivo Mayor agudo sobreimpuesto a una Distimia crónica preexistente.

ALGORITMO · CUADRO DEPRESIVO: ADAPTATIVO, DISTIMIA O DEPRESIÓN MAYOR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

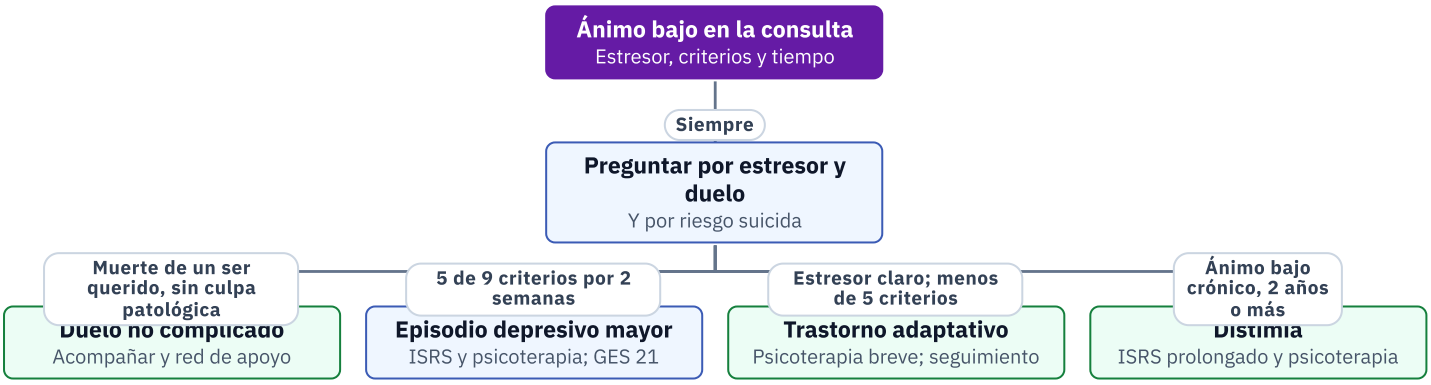


TABLA 17.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TRASTORNO ADAPTATIVO VS DISTIMIA VS DEPRESIÓN MAYOR VS DUELO NORMAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE PSIQ-05

ENTIDAD CLÍNICA	DESENCADENANTE	DURACIÓN TEMPORAL	GRAVEDAD / CRITERIOS DSM-5	TRATAMIENTO PRINCIPAL
Trastorno Adaptativo	Estresor identificable previo (< 3 meses)	< 6 meses tras cese del estresor	Malestar desproporcionado pero < 5 criterios TDM	Psicoterapia focalizada · No requiere ISRS
Distimia (T. Dep. Persistente)	Habitualmente insidioso / biológico	≥ 2 años continuos (≥ 1 año en niños)	Subumbral a TDM pero persistente crónico	ISRS (Sertralina/Escitalopram) + Psicoterapia
Episodio Depresivo Mayor	Variable (puede ser endógeno o reactivo)	≥ 2 semanas consecutivas	≥ 5 de 9 criterios con disfunción marcada	ISRS de 1.ª línea + Psicoterapia (GES N° 21)
Duelo Normal / No Complicado	Fallecimiento de ser querido	Meses (picos ante fechas conmemorativas)	Tristeza con autoestima conservada; olas de dolor	Acompañamiento empático y red de apoyo

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase psiq-05

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Estresor claro; conserva el disfrute	Psicoterapia breve	Iniciar antidepresivo
Adaptativo que no mejora	Reevaluar: ¿depresión?	Seguir igual sin revisar
Ánimo bajo de más de 2 años	Distimia: ISRS y TCC	Solo reposo o adaptativo

REGLA DE ORO **Estresor, menos de 5 criterios** — Dentro de 3 meses; termina en 6

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **21–22** (pág. 11) · solucionario pág. 25.

Clase 17.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA TIER 3

17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

★★★ PRIORIDAD ALTA
20 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.001	Trastorno de pánico con o sin agorafobia	Dx Específico · Tx Inicial · Seg Completo	
5.01.4.001	Estudio de hormonas tiroídeas		Interpreta y emplea

LO QUE TE PREGUNTAN

- El ataque de pánico se caracteriza por inicio brusco y alcance de intensidad máxima en menos de **10 minutos**, acompañado de miedo inminente a morir o volverse loco.
- En todo primer episodio de pánico es mandatorio descartar patología médica mediante examen físico y Electrocardiograma de 12 derivaciones.
- El Trastorno de Pánico exige ataques recurrentes e imprevistos seguidos de al menos **1 mes** de ansiedad anticipatoria o evitación conductual.
- Agorafobia es el temor a encontrarse en lugares o situaciones donde escapar sea difícil o no haya ayuda disponible ante una crisis de pánico.
- Las benzodiacepinas (Clonazepam o Lorazepam) se usan exclusivamente como rescate agudo o terapia puente en las primeras **2 a 4 semanas**.
- Los ISRS (Sertralina, Escitalopram, Paroxetina) son el tratamiento farmacológico de elección a largo plazo.

ALGORITMO · SÍNTOMAS DE PÁNICO: DE LA URGENCIA AL TRATAMIENTO DE FONDO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

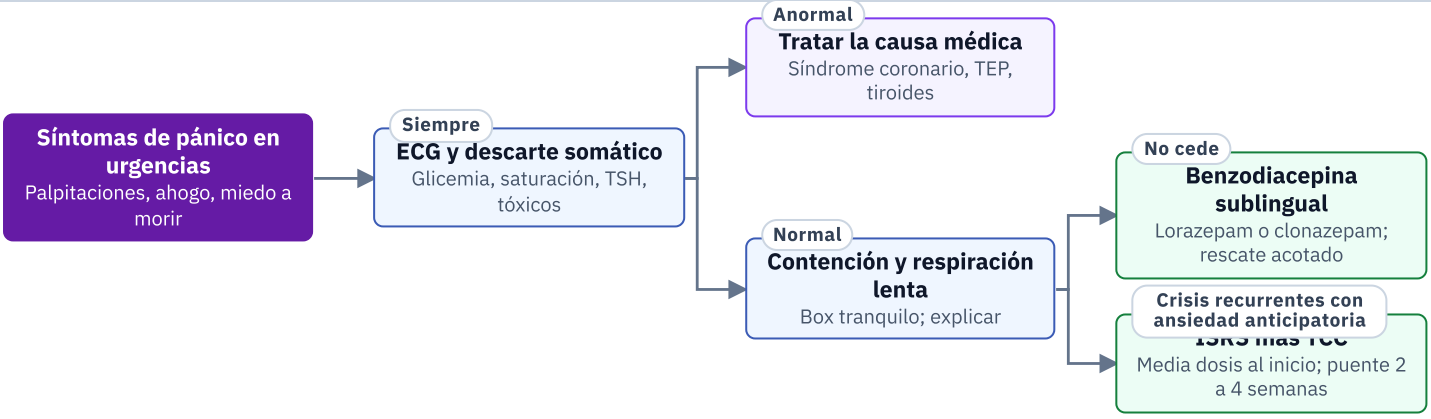


TABLA 17.6 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEL ATAQUE DE PÁNICO: CAUSAS PSIQUIÁTRICAS VS MÉDICAS

ETIOLOGÍA / CUADRO	HALLAZGOS CLÍNICOS CLAVE	EXAMEN DE DESCARTE INMEDIATO	DIFERENCIA CRÍTICA CON PÁNICO PRIMARIO
Trastorno de Pánico Primario	Pico en < 10 min, miedo a morir/volverse loco, temblor, desrealización	ECG normal, laboratorio basal normal	Ataques imprevistos recurrentes con ansiedad anticipatoria posterior
Síndrome Coronario Agudo (SCA)	Dolor retroesternal opresivo irradiado a mandíbula/brazo, diaforesis fría	ECG de 12 derivaciones + Troponinas seriadas	Dolor se prolonga > 20-30 min y suele asociarse a esfuerzo o factores CV
Tromboembolismo Pulmonar	Disnea súbita inexplicable, dolor pleurítico, taquipnea, taquicardia	AngioTAC de tórax / Dímero D	Hipoxemia marcada en gases arteriales (SatO2 < 90%)
Feocromocitoma	Tríada clásica: cefalea paroxística + diaforesis + palpitaciones con HTA	Metanefrinas libres en plasma o fraccionadas en orina 24 h	Crisis de hipertensión arterial maligna paroxística muy severa (> 200/120)
Hipertiroidismo / Tirotoxicosis	Pérdida de peso, temblor fino distal persistente, bocio, intolerancia al calor	TSH baja (< 0.01) y T4 libre elevada	Taquicardia y ansiedad sostenidas que no remiten entre episodios

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-06

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Primer episodio con dolor torácico	ECG y descartar lo somático	Rotular ansiedad sin examinar
Crisis aguda, ECG normal	Contención y lorazepam SL	Adenosina, morfina o intubar
Pánico recurrente	ISRS más TCC	Benzodiacepina en monoterapia

REGLA DE ORO **Crisis recurrentes más un mes** — Miedo a nuevas crisis o evitación

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **23–29** (págs. 11–12) · solucionario págs. 25–26.

Clase 17.6 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.036	Trastorno de ansiedad generalizada	Dx Específico	Tx Completo	Seg Completo
2.01.1.140	Trastornos de ansiedad generalizada	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
5.01.1.003	Trastornos fóbicos (fobia social y fobia específica)	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) exige preocupación excesiva e incontrolable por múltiples temas presente por **≥ 6 meses**.
- La tensión muscular marcada (bruxismo, contracturas cervicales) es el síntoma somático distintivo del TAG.
- Los ISRS (Escitalopram, Sertralina) y los IRSN (Venlafaxina) son los fármacos de primera elección para el TAG.
- La Fobia Social se define por el miedo irracional a la evaluación negativa, el escrutinio o la vergüenza en público.
- En la fobia social circunscrita a hablar en público (pánico escénico), el fármaco de rescate es Propranolol **10 a 40 mg** VO **1 hora** antes.

ALGORITMO · ANSIEDAD CRÓNICA: DEL SÍNTOMA AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.7 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TAG VS FOBIA SOCIAL VS TRASTORNO DE PÁNICO

CRITERIO CLÍNICO	TRASTORNO ANSIEDAD GENERALIZADA (TAG)	FOBIA SOCIAL (ANSIEDAD SOCIAL)	TRASTORNO DE PÁNICO
Foco de la ansiedad	Preocupación difusa por múltiples temas cotidianos	Miedo al escrutinio, vergüenza y evaluación ajena	Miedo paroxístico a morir o volverse loco
Curso temporal	Continuo y flotante (mínimo 6 meses)	Gatillado por exposición a situaciones sociales	Paroxístico en crisis (< 10 min de pico)
Síntomas cardinales	Tensión muscular, bruxismo, fatiga, insomnio	Rubor facial, temblor de voz, sudoración, tartamudeo	Palpitaciones masivas, opresión precordial, asfixia
Tratamiento de elección	ISRS (Escitalopram/Sertralina) + TCC	ISRS (generalizada) o Propranolol (actuación)	ISRS + TCC (BZD solo rescate agudo)
Error farmacológico	Prescribir Clonazepam o Diazepam crónico indefinido	No indicar Propranolol previo en pánico escénico	Asumir infarto y no iniciar ISRS tras descarte

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-07

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Preocupación múltiple, 6 meses	TAG: ISRS más TCC	Clonazepam indefinido
Evita presentaciones y reuniones	Fobia social: ISRS	Propranolol o alprazolam diario
Solo teme exponer en público	Propranolol antes del evento	Antidepresivo continuo de entrada

REGLA DE ORO **TAG: 6 meses, 3 síntomas** — Preocupación múltiple, tensión muscular

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **30–33** (págs. 12–13) · solucionario págs. 26–27.

Clase 17.7 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

17.8 Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
11 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.002 Trastorno obsesivo compulsivo — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El TOC se define por la presencia de obsesiones (pensamientos intrusivos egodistónicos) y compulsiones (actos para neutralizar la angustia) que consumen > **1 hora**/día.
- **Diferencia cardinal**: En el TOC el síntoma es egodistónico (el paciente reconoce lo absurdo y sufre); en el TPOC es egosintónico (cree que su perfeccionismo es virtuoso).
- La psicoterapia de elección indiscutida para el TOC es la Terapia Cognitivo-Conductual con Exposición y Prevención de Respuesta (EPR).
- **Farmacoterapia**: Los ISRS (Sertralina, Fluoxetina) son la 1.ª línea, pero requieren dosis más elevadas que en depresión (ej. Sertralina **200 mg**) y latencias de **8 a 12 semanas**.
- Clomipramina (tricíclico) es el fármaco más eficaz de segunda línea en casos resistentes.
- **Trampa del examen**: No confundir TOC con Trastorno de la Personalidad Obsesivo-Compulsivo; el paciente con TPOC no tiene obsesiones intrusivas ni rituales de lavado.

ALGORITMO · OBSESIONES Y COMPULSIONES: DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

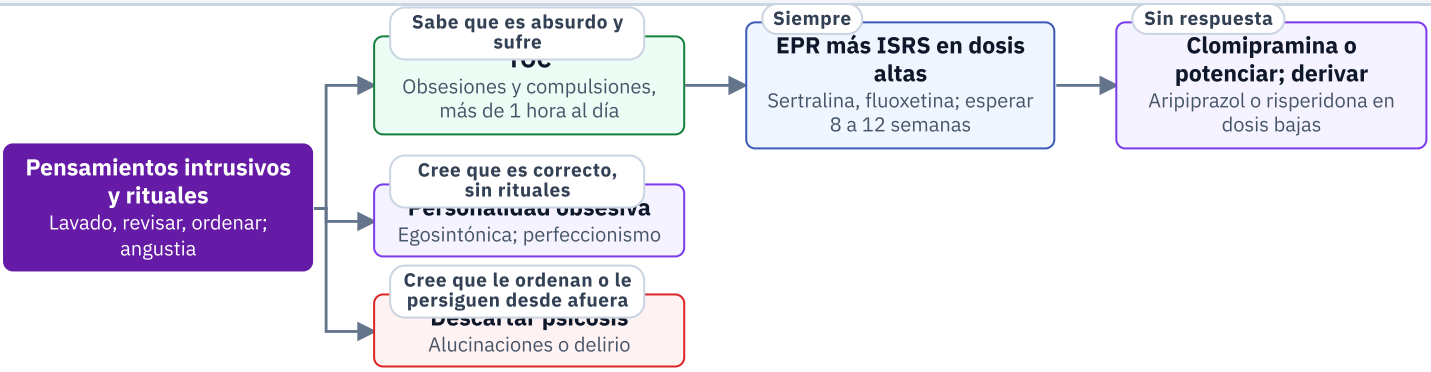


TABLA 17.8 · DIFERENCIACIÓN CONCEPTUAL: TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC) VS PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVA (TPOC)

CARACTERÍSTICA	TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO (TOC)	TRASTORNO PERSONALIDAD OBSESIVO-COMPULSIVO (TPOC)
Sintonía con el yo	EGODISTÓNICO: el síntoma es ajeno y causa gran sufrimiento	EGOSINTÓNICO: el sujeto considera que su conducta es correcta
Presencia de obsesiones	SIEMPRE presentes (ideas intrusivas, indeseadas, absurdas)	AUSENTES (no hay obsesiones intrusivas)
Presencia de rituales	SIEMPRE presentes (compulsiones para calmar la angustia)	AUSENTES (no hay rituales estereotipados)
Consumo de tiempo	Severo: consume horas al día limpiando, ordenando o contando	Dedicación excesiva al trabajo por perfeccionismo y minuciosidad
Tratamiento de elección	ISRS en dosis altas + TCC con Exposición y Prevención de Respuesta	Psicoterapia individual psicodinámica o cognitiva

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-08

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Sabe que es absurdo, igual lo hace	TOC	Psicosis o delirio
Imágenes de dañar a un hijo, con angustia	TOC; evaluar riesgo suicida	Depresión psicótica o TEPT
Miedo a ser pedófilo, reza y evita	TOC	Parafilia

REGLA DE ORO **Obsesión más compulsión** — Más de 1 hora al día; egodistónico

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **34–36** (pág. 13) · solucionario pág. 27.

Clase 17.8 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA

17.9 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
16 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.006	Trastorno por estrés postraumático	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
5.01.1.005	Trastorno agudo por estrés	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	
5.01.1.021	Trastornos disociativos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	

LO QUE TE PREGUNTAN

- **La frontera temporal diagnóstica es 1 mes**: síntomas entre **3 días** y **1 mes** = Estrés Agudo; síntomas > **1 mes** = TEPT.
- **Los 4 clústeres del TEPT son**: 1) Intrusión (flashbacks, pesadillas); 2) Evitación; 3) Alteraciones cognitivas/ánimo negativo; y 4) Hiperalerta.
- Los flashbacks son episodios disociativos donde el paciente siente y actúa como si el trauma estuviera ocurriendo nuevamente en el presente.
- Los ISRS (Sertralina y Paroxetina) son los psicofármacos de primera línea aprobados para el tratamiento del TEPT.
- La Prazosina (antagonista alfa-1) es el fármaco de elección para tratar las pesadillas traumáticas refractarias del TEPT.
- **Trampa del examen**: Las benzodiacepinas están contraindicadas como tratamiento del TEPT; no previenen el trastorno, interfieren con la psicoterapia de reprocesamiento y generan adicción.

ALGORITMO · TRAUMA: DEL TIEMPO TRANSCURRIDO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.9 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO VS TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT)

PARÁMETRO	TRASTORNO DE ESTRÉS AGUDO	TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO (TEPT)
Duración temporal	3 días a 1 mes (máximo 30 días post-trauma)	Más de 1 mes (crónico si > 3 meses; de inicio retardado si > 6 meses)
Clínica predominante	Gran componente disociativo inicial, aturdimiento, desrealización	Los 4 clústeres: Intrusión, Evitación, Cognición/ánimo negativo, Hiperalerta
Intervención inmediata	Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) y red familiar	TCC centrada en trauma / EMDR + Farmacoterapia de 1.ª línea
Farmacoterapia inicial	Generalmente NO requiere psicofármacos; NO dar BZD	ISRS (Sertralina / Paroxetina) + Prazosina si hay pesadillas
Error frecuente	Prescribir Clonazepam o forzar un debriefing traumático	Minimizar los flashbacks como si fueran "recuerdos normales"

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-09

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Trauma hace 2 semanas, hiperalerta	Estrés agudo	TEPT
Trauma hace 8 meses, evita y pesadillas	TEPT	Estrés agudo o adaptativo
Estresor sin intrusión ni hiperalerta	Trastorno adaptativo	Estrés agudo

REGLA DE ORO **Trauma más tiempo** — 3 días a 1 mes agudo; luego TEPT

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **47–54** (págs. 15–16) · solucionario págs. 29–30.

Clase 17.9 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS TIER 3

17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

Máxima rentabilidad · Patología psicótica angular del examen y garantía GES prioritaria

★★★ PRIORIDAD ALTA
34 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 34): Primer Episodio de Esquizofrenia en personas de 15 años y más · Sospecha con confirmación diagnóstica en ≤ 20 días por médico psiquiatra, e inicio de tratamiento farmacológico y psicosocial integral en ≤ 24 horas desde la confirmación.

5.01.1.010	Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
5.01.5.002	Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito		Realizar

LO QUE TE PREGUNTAN

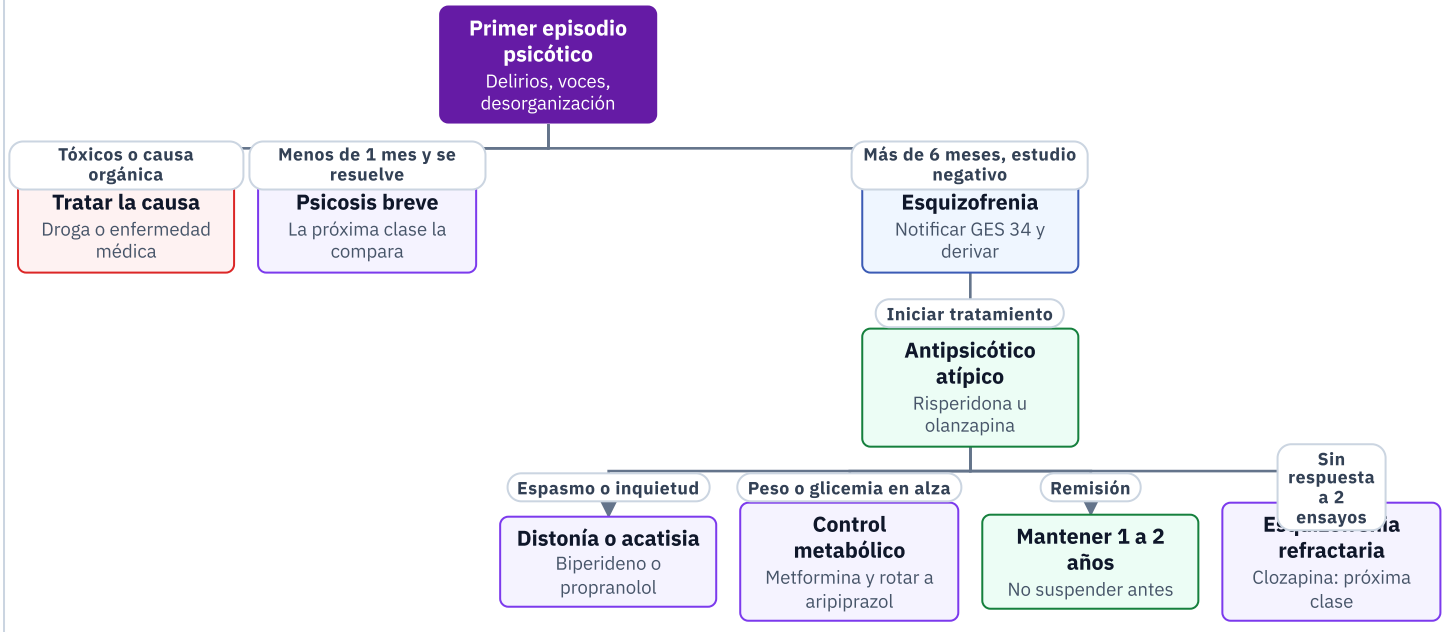
- El diagnóstico de Esquizofrenia según DSM-5 exige al menos **6 meses** de evolución total continua con al menos **1 mes** de síntomas activos (delirios, alucinaciones o habla desorganizada).
- En Chile, el Primer Episodio de Esquizofrenia en personas de **15 años** y más está garantizado por el GES N° 34 (confirmación en **≤ 20 días** e inicio de terapia en **≤ 24 h** post-confirmación).
- Todo primer episodio psicótico exige descarte toxicológico en orina y neuroimagen (TAC de encéfalo) para descartar causas secundarias.
- Los antipsicóticos de segunda generación (Risperidona, Olanzapina, Quetiapina, Aripiprazol) son la primera línea de tratamiento farmacológico.
- La distonía aguda (espasmo ocular o cervical en las primeras **48 h**) se trata de urgencia con Biperideno **5 mg** IM o EV.
- La acatisia (inquietud motora subjetiva intolerable) se trata de primera línea con Propranolol o benzodiacepinas.
- Tras la remisión de un primer episodio psicótico, el tratamiento antipsicótico debe mantenerse de forma continua durante al menos **1 a 2 años** para prevenir recaídas.



CRISIS OCULÓGIRA
The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 506

ALGORITMO · PRIMER EPISODIO PSICÓTICO: DEL ESTUDIO AL SEGUIMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **38–44** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 17.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★★ PRIORIDAD ALTA

TABLA 17.10 · SÍNTOMAS POSITIVOS VS SÍNTOMAS NEGATIVOS EN ESQUIZOFRENIA Y VÍAS NEUROBIOLÓGICAS

CATEGORÍA SINTOMÁTICA	MANIFESTACIONES CLÍNICAS CLAVE	VÍA DOPAMINÉRGICA COMPROMETIDA	RESPUESTA FARMACOLÓGICA
Síntomas Positivos	Delirios (persecución, perjuicio, místicos), alucinaciones auditivas, habla desorganizada	Hiperactividad mesolímbica (exceso D2)	Excelente respuesta a antipsicóticos (bloqueo D2)
Síntomas Negativos	Aplanamiento afectivo, abulia (falta de voluntad), alogia (pobreza del habla), anhedonia	Hipoactividad mesocortical prefrontal	Pobre respuesta a antipsicóticos; mejor con atípicos y psicosocial
Síntomas Cognitivos	Déficit de memoria de trabajo, atención ejecutiva alterada, procesamiento lento	Disfunción cortical prefrontal y del hipocampo	Rehabilitación cognitiva; no remiten plenamente con fármacos
Síntomas Afectivos	Disforia, depresión post-psicótica, riesgo suicida elevado	Disfunción límbico-cortical compleja	Manejo con antidepresivos cautelosos o estabilizadores

TRAMPAS EUNACOM clase psiq-10

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Primer episodio con tóxicos negativos	Notificar GES, derivar, atípico	Esperar o dar solo psicoterapia
Delirios y voces resueltos; sigue apático	Negativos: apoyo psicosocial	Subir mucho el antipsicótico
Espasmo de cuello a las 24 horas	Distonía: biperideno	Pensar en conversión o convulsión
Inquietud de piernas con risperidona	Acatisia: propranolol	Subir el antipsicótico
Aumento de peso y glicemia con olanzapina	Metformina y rotar a aripiprazol	Suspender sin reemplazo

REGLA DE ORO **Positivos, negativos y 6 meses** — Uno entre delirio, alucinación, habla

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico mayor crónico, heterogéneo y discapacitante, con una prevalencia cercana al 1% de la población mundial y pico de inicio en el adulto joven (18-25 años en hombres, 25-35 años en mujeres). Su etiopatogenia es neuroevolutiva y multifactorial, involucrando una disfunción del sistema dopaminérgico con hiperactividad en la vía mesolímbica (responsable de los síntomas positivos: delirios y alucinaciones) e hipoactividad en la vía mesocortical (responsable de los síntomas negativos y cognitivos: abulia, aplanamiento afectivo y alogia). En Chile está protegida por la Garantía GES N° 34. El médico general debe saber reconocer el debut psicótico, descartar consumo de sustancias y causas médicas orgánicas, e iniciar antipsicóticos de segunda generación vigilando los efectos adversos metabólicos y extrapiramidales.

TABLA 17.10.B · PROTOCOLO DE MANEJO DE REACCIONES ADVERSAS MOTORAS POR ANTIPSICÓTICOS

EFECTO ADVERSO MOTOR	CRONOLOGÍA TÍPICA	SIGNOS CLÍNICOS CARDINALES	TRATAMIENTO MÉDICO INMEDIATO
Distonía Aguda	Primeras 24 a 48 horas post-inicio	Crisis oculógiras, tortícolis espasmódica, trismus, laringoespasmo	Biperideno 5 mg IM/EV (repetible en 30 min) o Difenhidramina
Acatisia	Primeros días a semanas	Inquietud subjetiva intolerable, necesidad de caminar, incapacidad de sentarse	Propranolol 20-80 mg/día o Clonazepam; reducir dosis de antipsicótico
Parkinsonismo	Primeras semanas a meses	Temblor de reposo, rigidez plástica en rueda dentada, marcha a pequeños pasos	Biperideno 2-4 mg/día VO transitorio o rotar a antipsicótico atípico
Discinesia Tardía	Años de tratamiento continuo	Movimientos coreoatetoides peribucales ("chupeteo", muecas involuntarias)	Rotar a Clozapina · PROHIBIDO dar Biperideno (la empeora) · Valbenazina

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **38–44** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 17.10 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma

★★★ PRIORIDAD ALTA
35 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía Explícita en Salud (GES N° 34): Canasta de Esquizofrenia Refractaria · Programa Nacional de Farmacovigilancia de Clozapina con monitoreo hematológico obligatorio.

5.01.1.010	Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
1.08.4.008	Hemograma	Interpreta y emplea	

LO QUE TE PREGUNTAN

- Esquizofrenia refractaria se define por el fracaso a **≥ 2 ensayos** con antipsicóticos a dosis plenas por **≥ 6 semanas** (al menos un atípico).
- La Clozapina es el fármaco de elección indiscutido en esquizofrenia refractaria y en psicosis con conducta suicida persistente.
- **Calendario de hemogramas con clozapina**: semanal durante los primeros **6 meses**, quincenal de los **6 a 12 meses**, y mensual de por vida.
- Si el RAN cae por debajo de 1.000/mm³, se debe suspender la clozapina de inmediato y queda formalmente proscrita la reexposición de por vida.
- La Clozapina no produce síntomas extrapiramidales ni discinesia tardía, pero puede causar miocarditis, convulsiones e íleo paralítico fatal.

ALGORITMO · CLOZAPINA: DE LA INDICACIÓN AL CONTROL DEL RAN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

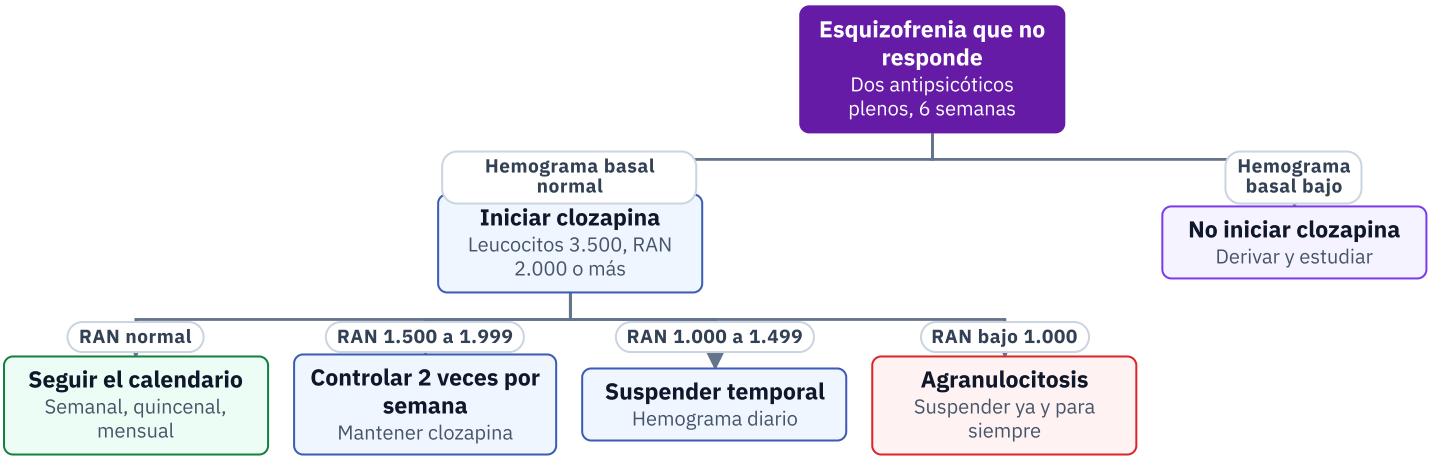


TABLA 17.11 · PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y MONITOREO HEMATOLÓGICO DE CLOZAPINA SEGÚN NIVELES DE RAN

NIVEL DE RAN (NEUTRÓFILOS)	ESTADO HEMATOLÓGICO	CONDUCTA MÉDICA INMEDIATA	POSIBILIDAD DE REEXPOSICIÓN
RAN ≥ 2.000/mm³	Normal / Seguro	Continuar tratamiento según calendario habitual (semanal -> quincenal -> mensual)	Uso continuado autorizado
RAN 1.500 – 1.999/mm³	Neutropenia Leve	Continuar clozapina pero intensificar controles a dos veces por semana hasta normalizar	Permitida bajo vigilancia estrecha
RAN 1.000 – 1.499/mm³	Neutropenia Moderada	Suspender temporalmente clozapina · Hemograma diario · Reanudar al superar 1.500	Permitida tras recuperación completa
RAN < 1.000/mm³	AGRANULOCITOSIS SEVERA	SUSPENSIÓN INMEDIATA Y DEFINITIVA · Aislamiento protector · G-CSF	FORMALMENTE PROHIBIDA DE POR VIDA

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-11

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
2 antipsicóticos plenos, 6 semanas, sin respuesta	Clozapina con hemograma	Subir una tercera vez el mismo fármaco
Hemograma: semanal, quincenal, mensual	Seis meses, seis meses, luego de por vida	Cambiar los plazos
RAN de 1.200	Suspender temporal; hemograma diario	Tratarlo como agranulocitosis definitiva

REGLA DE ORO **Refractaria: 2 fármacos, 6 semanas** — Uno atípico, adherencia verificada

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **45–46** (pág. 15) · solucionario pág. 29.

Clase 17.11 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.12 Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve

★★★ PRIORIDAD ALTA
34 preguntas reales 2013–2025

GES Norma Técnica de Salud Mental MINSAL · Sin cobertura GES directa para trastorno delirante crónico no esquizofrénico · Derivación a COSAM.

5.01.1.010 Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- El Trastorno Psicótico Breve dura entre **1 día** y menos de **1 mes**, resolviendo con restitución completa ad integrum.
- El Trastorno Esquizofreniforme tiene una duración de entre 1 y **6 meses**; si los síntomas superan los **6 meses** se diagnostica Esquizofrenia.
- El Trastorno Delirante Crónico exige delirios no bizarros de **≥ 1 mes** de duración, con preservación de la funcionalidad global fuera del núcleo delirante.
- En el trastorno delirante NO hay alucinaciones prominentes, ni lenguaje desorganizado, ni síntomas negativos.
- El subtipo celotípico (Síndrome de Otelo) es de muy alto riesgo de violencia física hacia la pareja y exige evaluación prioritaria de seguridad.

ALGORITMO · PSICOSIS NO ESQUIZOFRÉNICAS: DEL RELOJ AL DIAGNÓSTICO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.12 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CRONOLÓGICO Y CLÍNICO DEL ESPECTRO PSICÓTICO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE PSIQ-12

TRASTORNO PSICÓTICO	DURACIÓN TEMPORAL REQUERIDA	TIPO DE DELIRIO Y SÍNTOMAS	NIVEL DE DETERIORO FUNCIONAL	PRONÓSTICO GLOBAL
Trastorno Psicótico Breve	≥ 1 día y < 1 mes (< 30 días)	Florido, polimorfo, reactivo a estresor	Grave agudo pero con restitución completa ad integrum	Excelente
Trastorno Esquizofreniforme	≥ 1 mes y < 6 meses	Idéntico a esquizofrenia (positivos y negativos)	Moderado a severo durante el episodio	Reservado (60-80% progresa a esquizofrenia)
Esquizofrenia	≥ 6 meses continuos (≥ 1 mes activo)	Bizarro, delirios de influencia, alucinaciones auditivas	Severo, progresivo, afecto plano y abulia	Crónico / Manejo de rehabilitación GES
Trastorno Delirante Crónico	≥ 1 mes (suele llevar años)	No bizarro, bien estructurado y verosímil (celos, daño)	CONSERVADO en áreas no vinculadas al delirio	Crónico refractario a psicofármacos

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase psiq-12

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Trabaja bien, convicción fija y sin voces	Trastorno delirante	Esquizofrenia
Convicción de infidelidad sin pruebas	Delirante celotípico; evaluar riesgo	Trastorno obsesivo o celos normales
Convicción de enfermedad que los exámenes niegan	Delirante somático	Hipocondría o demencia

REGLA DE ORO **Breve: menos de 1 mes** — Sana del todo; esquizofreniforme: 1 a 6 meses

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **56–57** (págs. 16–17) · solucionario pág. 30.

Clase 17.12 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS TIER 3

17.13 Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

PRIORIDAD BAJA
5 preguntas reales 2013–2025

Máxima gravedad clínica · Urgencia médica iatrogénica de diagnóstico diferencial obligatorio

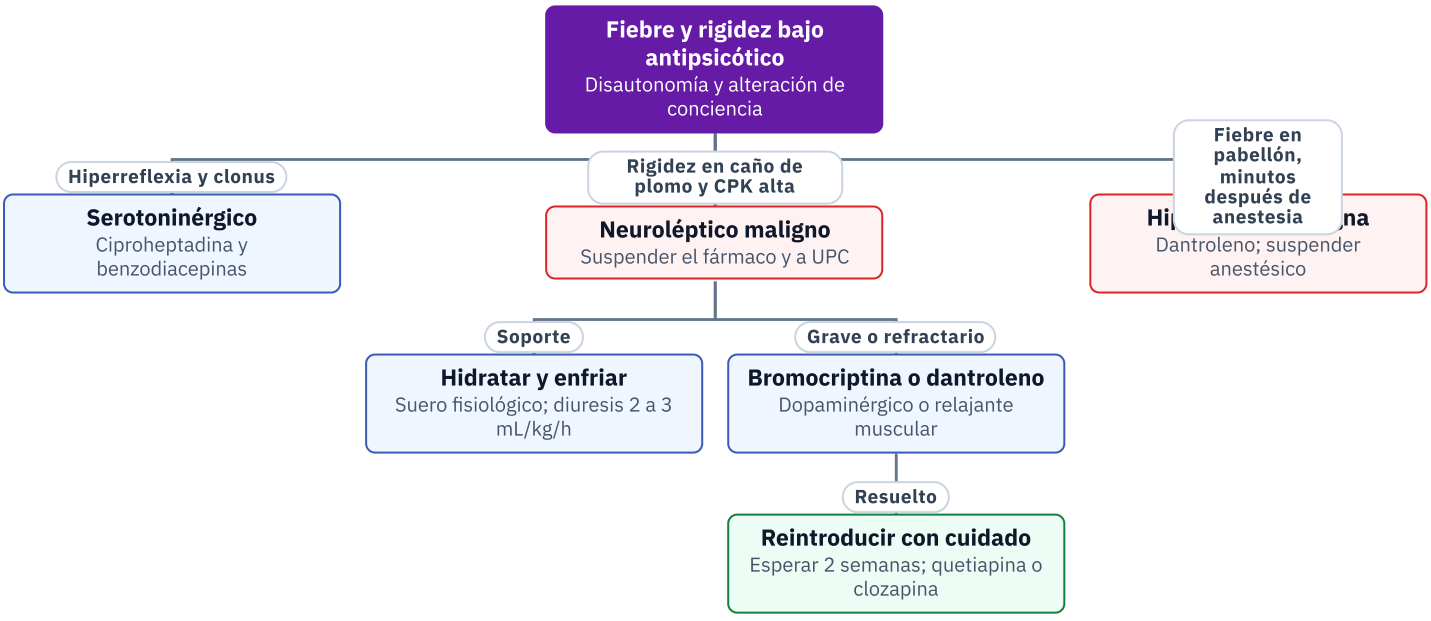
5.01.5.002	Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito	Realizar

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El Síndrome Neuroléptico Maligno se caracteriza por la tétrada**: hipertermia, rigidez muscular en "caño de plomo", inestabilidad autonómica y alteración del sensorio.
- La elevación masiva de la CPK (> 1.000 a > **10.000 UI**/L) secundaria a rabdomiólisis es el hallazgo bioquímico distintivo del SNM.
- **Diferencia cardinal con el Síndrome Serotoninérgico**: el SNM cursa con rigidez en caño de plomo e hiporreflexia; el serotoninérgico cursa con hiperreflexia marcada y clonus.
- La primera medida terapéutica obligatoria y vital es la suspensión inmediata de todos los fármacos antipsicóticos.
- La hidratación endovenosa masiva con suero salino para forzar diuresis (> **2 mL/kg**/h) es indispensable para evitar la necrosis tubular aguda por mioglobinuria.
- Los fármacos específicos de rescate en UPC son la Bromocriptina (agonista D2) y el Dantroleno sódico EV (relajante muscular del retículo sarcoplásmico).
- **Trampa de examen**: Ante la sospecha de SNM, jamás administrar antipiréticos comunes esperando que baje la fiebre sin suspender el antipsicótico; el paracetamol no revierte la hipertermia central dopaminérgica.

ALGORITMO · SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO: DEL EXAMEN A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **58–61** (pág. 17) · solucionario pág. 31.

Clase 17.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.13 Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★☆☆ PRIORIDAD BAJA

TABLA 17.13 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLÍNICO: SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO VS SÍNDROME SEROTONINÉRGICO

CARACTERÍSTICA	SÍNDROME NEUROLÉPTICO MALIGNO (SNM)	SÍNDROME SEROTONINÉRGICO (CRITERIOS DE HUNTER)
Fármacos desencadenantes	Antipsicóticos (Haloperidol, Risperidona) · Retiro de Levodopa	ISRS, IRSN, Tramadol, Tricíclicos, IMAO, MDMA (éxtasis)
Comienzo temporal	Subagudo e insidioso (días a semanas post-cambio de dosis)	Hiperagudo (horas después de una coingesta o sobredosis)
Tono muscular	RIGIDEZ EN "CAÑO DE PLOMO" extrema, uniforme y generalizada	Rigidez leve a moderada (predomina en miembros inferiores)
Reflejos osteotendinosos	HIPORREFLEXIA o reflejos disminuidos por hipertonía plástica	HIPERREFLEXIA MARCADA Y CLONUS (espontáneo / inducible)
Pupilas y Gastrointestinal	Pupilas normales · Estreñimiento por anticolinérgicos	MIDRIASIS bilateral marcada · DIARREA profusa y borborigmos
Tratamiento específico	Dantroleno EV + Bromocriptina (agonista dopaminérgico)	Ciproheptadina (antagonista 5-HT2A) + Benzodiacepinas

TRAMPAS EUNACOM clase psiq-13

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Fiebre, rigidez y CPK alta con haloperidol	Suspender y llevar a UPC	Subir el antipsicótico o dar antibiótico solo
Rigidez con hiperreflexia y clonus	Serotoninérgico: ciproheptadina	Dantroleno y bromocriptina
Fiebre alta sin respuesta a paracetamol	Enfriar físicamente	Insistir con antipiréticos

REGLA DE ORO **Fiebre, caño de plomo, disautonomía, conciencia** — Tras subir o iniciar un antipsicótico

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM) es una reacción adversa idiosincrática potencialmente mortal desencadenada por el bloqueo dopaminérgico agudo y masivo en los ganglios basales y el hipotálamo, secundario al uso de cualquier fármaco antipsicótico (con mayor riesgo en neurolépticos típicos de alta potencia como Haloperidol o tras la suspensión brusca de agonistas dopaminérgicos en pacientes con Parkinson). Presenta una mortalidad histórica del 10 al 20% atribuida a falla multiorgánica y shock. En el EUNACOM se evalúa con rigor: la tétrada clásica (hipertermia, rigidez extrema en "tubo de plomo", inestabilidad autonómica y alteración del sensorio), la elevación extrema de la creatina fosfoquinasa (CPK), la diferenciación con el Síndrome Serotoninérgico (donde hay hiperreflexia y clonus, no rigidez plástica), la suspensión inmediata del fármaco y la reposición hídrica agresiva para prevenir la falla renal por rabdomiólisis.

TABLA 17.13.B · PROTOCOLO TERAPÉUTICO ESCALONADO EN UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO PARA SNM

FASE / OBJETIVO	FÁRMACO O INTERVENCIÓN	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	METAS CLÍNICAS Y ADVERTENCIAS
1. Medida Vital Inmediata	SUSPENSIÓN DE ANTIPSICÓTICOS	Cese total e inmediato de todo bloqueador D2	No retrasar la suspensión esperando exámenes de laboratorio
2. Soporte Hemodinámico	Suero Fisiológico al 0.9% enérgico	3.000 a 6.000 mL en 24 h endovenoso	Meta estricta: Diuresis > 2 a 3 mL/kg/h para lavado renal
3. Enfriamiento Físico	Medidas físicas externas activas	Compresas frías en cuello/axilas/ingles, mantas térmicas	Evitar antipiréticos comunes (paracetamol no actúa en termorregulación hipotalámica)
4. Agonista Dopaminérgico	Bromocriptina (oral o sonda)	2.5 a 5 mg cada 8 horas (titulable hasta 20 mg/día)	Restaura el tono dopaminérgico central en hipotálamo
5. Relajante Muscular Directo	Dantroleno Sódico EV	1 a 2.5 mg/kg en bolo EV cada 6 h (máximo 10 mg/kg/día)	Bloquea canal de rianodina muscular · Suspender si hepatotoxicidad

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **58–61** (pág. 17) · solucionario pág. 31.

Clase 17.13 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS TIER 3

17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
8 preguntas reales 2013–2025

5.01.2.002 Agitación psicomotora — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

5.01.1.014 Delirium — Dx Específico · Tx Completo · Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- En todo paciente agitado es obligatorio descartar primero causas orgánicas potencialmente reversibles: glicemia capilar (hipoglicemia) y oximetría (hipoxia).
- **El protocolo de contención es estrictamente escalonado**: 1) Verbal y ambiental; 2) Farmacológica; 3) Mecánica física de último recurso.
- La contención verbal exige mantener siempre la vía de escape despejada entre el médico y la puerta del box, sin acorralar al paciente.
- El esquema farmacológico intramuscular de primera elección en agitación aguda severa es la combinación de Haloperidol **5 mg** IM + Lorazepam **2 mg** IM.
- La combinación de Haloperidol con Lorazepam ofrece mayor rapidez de sedación, menor dosis requerida y prevención de la distonía aguda.

ALGORITMO · PACIENTE AGITADO: DE LA CAUSA A LA CONTENCIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

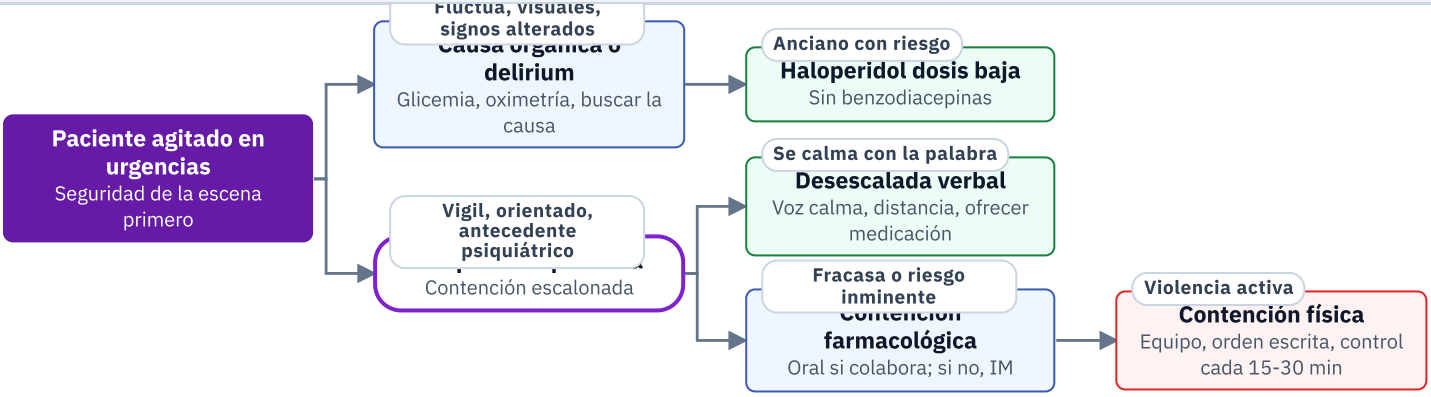


TABLA 17.14 · ETIOLOGÍA DE LA AGITACIÓN PSICOMOTORA: DIFERENCIAS ENTRE ORIGEN ORGÁNICO Y PSIQUIÁTRICO

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE PSIQ-14

PARÁMETRO CLÍNICO	AGITACIÓN DE CAUSA ORGÁNICA (DELIRIUM)	AGITACIÓN DE CAUSA PSIQUIÁTRICA PRIMARIA
Nivel de conciencia	FLUCTUANTE, confuso, desorientado témporo-espacialmente	VIGIL, lúcido, orientado en tiempo y espacio
Comienzo temporal	Agudo / Súbito (horas a días), empeora en la noche ("sundowning")	Insidioso o subagudo con antecedentes psiquiátricos previos
Alucinaciones	Predominantemente VISUALES o táctiles (zoopsias, sombras)	Predominantemente AUDITIVAS complejas o en tercera persona
Examen físico / Signos vitales	FRECUENTEMENTE ALTERADOS (fiebre, sudoración, taquicardia, focalidad)	Habitualmente normales salvo taquicardia por esfuerzo motor
Manejo prioritario	TRATAR LA CAUSA MÉDICA DE BASE (HGT, oxígeno, antibióticos, sonda)	Contención escalonada + Antipsicóticos / Benzodiacepinas

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase psiq-14

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Agitado y agresivo verbal, sin violencia física	Contención verbal y ambiental	Sujetar o inyectar de entrada
Agitación sin causa conocida	Glicemia y oximetría primero	Sedar sin descartar lo orgánico
Psicosis agitada que rechaza la vía oral	Haloperidol más lorazepam IM	Olanzapina IM más lorazepam IM

REGLA DE ORO **Glicemia y oximetría primero** — Delirium: tratar la causa

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **62–66** (págs. 17–18) · solucionario págs. 31–32.

Clase 17.14 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

17.19 Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
8 preguntas reales 2013–2025

5.01.3.001	Clasificaciones en psiquiatría	Conocimiento general	5.01.3.005	Higiene del sueño	Conocimiento general
5.01.1.022	Trastornos facticios	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	5.01.3.009	Nociones de psiquiatría forense	Conocimiento general

LO QUE TE PREGUNTAN

- El diagnóstico psiquiátrico es clínico y sindromático; la CIE-10 (F00-F99) es la clasificación oficial en Chile para ficha, GES y licencias, y el DSM-5 aporta los criterios.
- **Higiene del sueño**: horarios fijos, cama solo para dormir, sin siestas largas, cafeína ni alcohol; es la primera medida, antes de cualquier hipnótico.
- La TCC para insomnio es la primera línea del insomnio crónico; los hipnóticos se usan solo **2-4 semanas** y no se usa quetiapina para el insomnio simple.
- **Trastorno facticio**: produce síntomas de forma intencional para asumir el rol de enfermo, sin beneficio externo; la simulación sí tiene un motivo externo y no es enfermedad mental.
- Los trastornos somatomorfos y conversivos son involuntarios; el facticio impuesto a otro (cuidador a un niño) es abuso infantil y obliga a proteger y notificar.

ALGORITMO · SÍNTOMA SIN CAUSA ORGÁNICA: FACTICIO, SIMULACIÓN O SOMATOMORFO

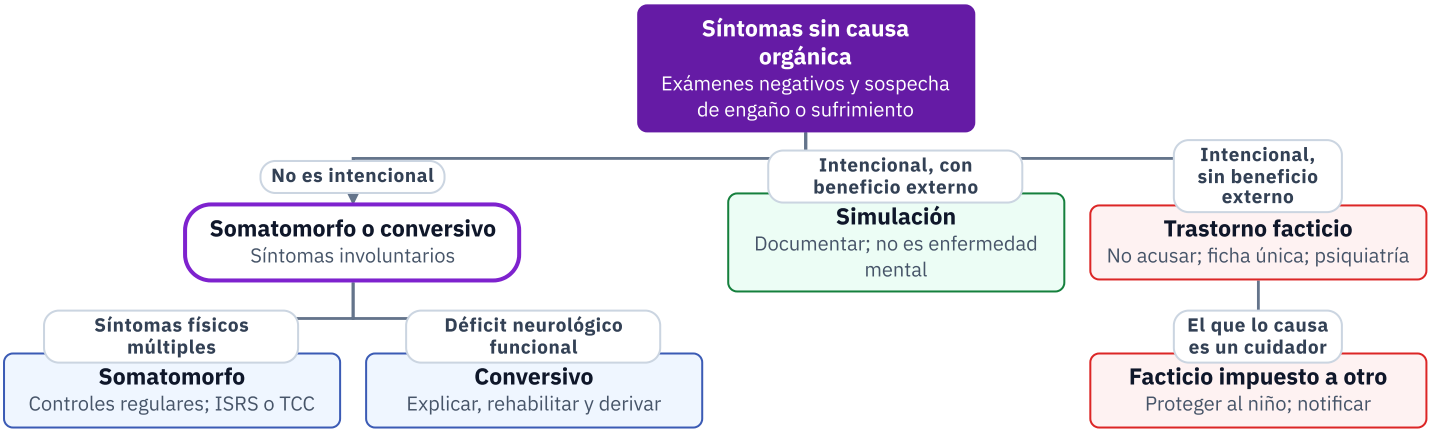


TABLA 17.19 · FACTICIO, SIMULACIÓN, SOMATOMORFO Y CONVERSIVO: CÓMO DISTINGUIRLOS

ENTIDAD	¿ES INTENCIONAL?	MOTIVACIÓN	CONDUCTA DEL MÉDICO GENERAL
Trastorno facticio	Sí, con engaño	Asumir el rol de enfermo (ganancia psicológica)	Evitar procedimientos, interconsulta psiquiátrica, no acusar
Simulación	Sí, consciente	Beneficio externo: licencia, dinero, drogas, evitar un castigo	Documentar objetivamente; no es enfermedad mental
Somatomorfo	No	Sufrimiento por síntomas físicos sin causa orgánica	Controles regulares, no repetir exámenes, ISRS/TCC
Conversivo	No	Déficit neurológico funcional ligado a un estrés	Explicar con claridad, rehabilitación, derivar
Facticio impuesto a otro	Sí, hacia un tercero	Rol de cuidador de un niño enfermo	Proteger al menor y notificar a la justicia de familia

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-19

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Registrar diagnóstico para licencia y GES	CIE-10 de la OMS	DSM-5 o una escala
Insomnio leve sin causa clara	Higiene del sueño	Zolpidem o quetiapina de entrada
Toma laxantes a escondidas, sin ganancia	Trastorno facticio	Simulación o conversivo

REGLA DE ORO **CIE-10: oficial en Chile** — DSM-5 aporta criterios

PRACTICA Sin preguntas de este tema en el **Libro Gordo Psiquiatría General**: usa las preguntas de la clase (QR).

Clase 17.19 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL TIER 3

17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

Máxima rentabilidad · Causa líder de morbimortalidad psiquiátrica y urgencias toxicológicas en Chile

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
12 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía GES Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol y Drogas en personas menores de 20 años · Programa Nacional de Detección e Intervención Breve del Alcoholismo MINSAL en APS.

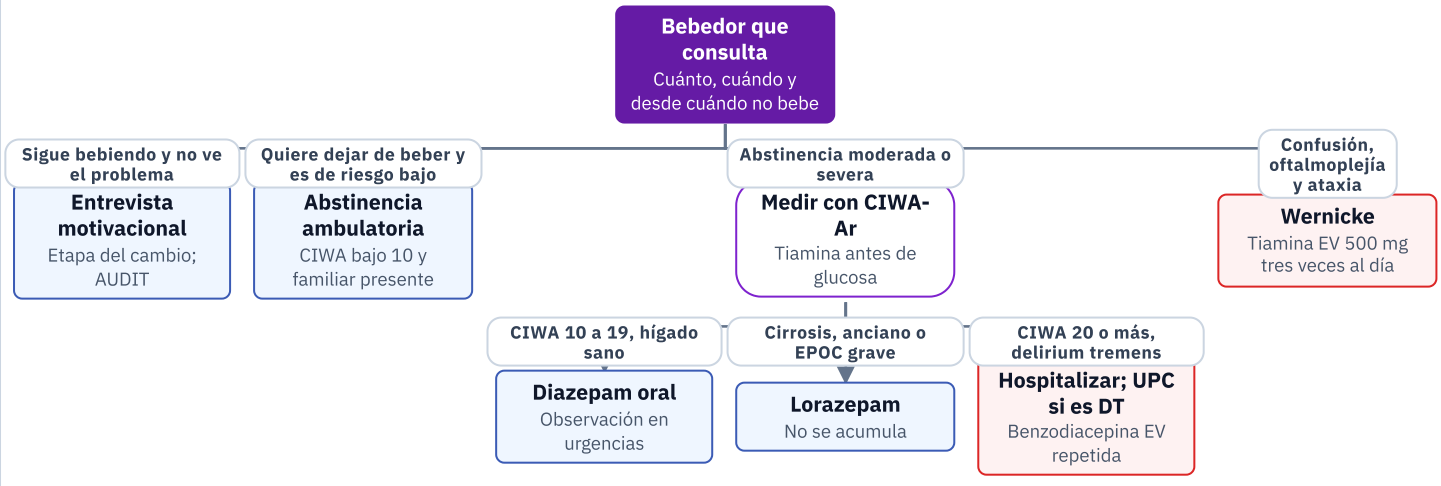
5.01.1.012	Dependencia de alcohol	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Completo
1.10.2.004	Estado confusional agudo (alcohólico, tóxico metabólico)	Dx Específico	Tx Inicial	Seg Completo
1.10.3.001	Manifestaciones neurológicas de abuso de sustancias y alcohol	Conocimiento general		
5.01.5.001	EBBA (Escala breve de Beber Anormal)	Realizar		
1.02.2.004	Déficit agudo de tiamina	Dx Específico	Tx Completo	Seg Derivar

LO QUE TE PREGUNTAN

- La Encefalopatía de Wernicke es causada por déficit de tiamina (B1); su tríada clásica es oftalmoplejía (VI par), ataxia y confusión.
- **REGLA DE ORO VITAL**: Todo paciente alcohólico debe recibir TIAMINA EV/IM antes de cualquier solución glucosada para evitar precipitar un Wernicke irreversible.
- El Síndrome de Korsakoff es la secuela crónica e irreversible del Wernicke no tratado, manifestada por amnesia anterógrada severa y confabulación.
- La alucinosis alcohólica ocurre a las **12-24 h** con alucinaciones pero SENSORIO LÚCIDO; el Delirium Tremens ocurre a las **48-72 h** con CONFUSIÓN y disautonomía.
- El Delirium Tremens es una emergencia médica vital (mortalidad hasta **15%**) caracterizada por confusión, agitación, fiebre y zoopsias.
- El Diazepam es la benzodiacepina de elección en abstinencia alcohólica en pacientes con función hepática conservada.
- El Lorazepam es la benzodiacepina obligatoria de elección en pacientes con CIRROSIS HEPÁTICA o insuficiencia hepatocelular porque no genera metabolitos activos.

ALGORITMO · ALCOHOL: DE LA ABSTINENCIA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **67–72** (págs. 18–19) · solucionario págs. 32–33.

Clase 17.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

CONTINUACIÓN · TABLA, TRAMPAS Y REGLA DE ORO

★★☆ PRIORIDAD MEDIA

TABLA 17.15 · FASES TEMPORALES DE LA ABSTINENCIA ALCOHÓLICA: CRONOLOGÍA, CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

ETAPA / SÍNDROME	TIEMPO POST-ÚLTIMA INGESTA	MANIFESTACIONES CLÍNICAS CARDINALES	NIVEL DE CONCIENCIA
Abstinencia Leve / Temblor	6 a 12 horas	Temblor fino distal, sudoración, taquicardia, náuseas, ansiedad	Vigil y orientado
Alucinosis Alcohólica	12 a 24 horas	Alucinaciones visuales o auditivas floridas sin amnesia posterior	SENSORIO LÚCIDO Y ORIENTADO (Diferencia con DT)
Convulsiones de Abstinencia	12 a 48 horas	Crisis tónico-clónicas generalizadas, únicas o en salvas breves	Estupor postictal transitorio breve
Delirium Tremens	48 a 96 horas (hasta 7 días)	Confusión global, desorientación, disautonomía severa, zoopsias, fiebre	COMPROMISO SEVERO DE CONCIENCIA Y CONFUSIÓN
Encefalopatía de Wernicke	Cualquier momento (déficit B1)	Tríada: Oftalmoplejía (VI par) + Ataxia de la marcha + Delirium	Confusional agudo / Estupor progresivo

TRAMPAS EUNACOM clase psiq-15

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Alcohólico confuso con hipoglicemia	Tiamina, luego glucosa	Glucosa sola
Alucinaciones y está orientado	Alucinosis alcohólica	Delirium tremens
48 a 96 h, confuso, fiebre, zoopsias	Delirium tremens: benzodiacepina	Haloperidol solo
Abstinencia en cirrótico	Lorazepam	Diazepam
Convulsión de abstinencia	Benzodiacepina aguda	Fenitoína de mantención

REGLA DE ORO **Alucinosis: lúcido; delirium tremens: confuso** — Doce a veinticuatro horas; cuarenta y ocho a noventa y seis

¿POR QUÉ SE PREGUNTA?

El trastorno por uso de alcohol es la principal adicción en Chile y la causa de mayor carga de enfermedad por discapacidad y muerte prematura en la población adulta. La dependencia etílica genera una adaptación neuroquímica profunda caracterizada por la desensibilización de los receptores gabaérgicos inhibidores y la hipersensibilización de los receptores glutamatérgicos NMDA excitadores. Cuando el consumo se interrumpe de forma brusca, se produce una tormenta hiperglutamatérgica y noradrenérgica que se manifiesta clínicamente como el Síndrome de Abstinencia Alcohólica, cuyas complicaciones mortales son las convulsiones de abstinencia, el Delirium Tremens (mortalidad hasta el 5%) y la Encefalopatía de Wernicke irreversible. En el EUNACOM se evalúan con rigor absoluto dos axiomas: la administración de Tiamina EV SIEMPRE antes de sueros glucosados, y el uso de benzodiacepinas orales/EV tituladas por la escala CIWA-Ar.

TABLA 17.15.B · PROTOCOLO FARMACOLÓGICO INTEGRAL EN TRASTORNO POR USO DE ALCOHOL

FASE TERAPÉUTICA	FÁRMACO DE ELECCIÓN	DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN	REGLAS DE ORO Y ADVERTENCIAS CRÍTICAS
Prevención de Wernicke	Tiamina (Vitamina B1)	100 a 300 mg EV o IM al día por 3 a 5 días	ADMINISTRAR SIEMPRE ANTES DE CUALQUIER SUERO GLUCOSADO
Abstinencia Hepática Normal	Diazepam VO o EV	10 a 20 mg VO c/1-2 h según escala CIWA-Ar	Vida media larga con metabolitos activos · Autotitulación suave
Abstinencia en Cirrótico	Lorazepam VO o SL	2 a 4 mg VO/SL cada 2 horas según CIWA-Ar	No genera metabolitos activos · No se acumula en falla hepática
Deshabituación (Anticraving)	Naltrexona oral	50 mg una vez al día por vía oral	Reduce el placer del alcohol · Prohibido si consume opioides o hepatitis
Deshabituación (Terapia Aversiva)	Disulfiram oral	250 mg al día por vía oral bajo supervisión	Inhibe aldehído deshidrogenasa · Reacción vómitos/shock con alcohol

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **67–72** (págs. 18–19) · solucionario págs. 32–33.

Clase 17.15 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
13 preguntas reales 2013–2025

GES Garantía GES Consumo de Drogas en menores de 20 años · Programa Nacional SENDA / MINSAL.

5.01.2.003	Intoxicación por sustancias psicoactivas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	5.01.1.013	Dependencia de otras drogas	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar
5.01.1.011	Consumo perjudicial de alcohol y drogas	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo	5.01.1.035	Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes	Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo
5.01.3.011	Prevención: Alcohol, tabaco, drogas. Modelo de prevención primaria.	Conocimiento general	+ 2 códigos relacionados: 5.01.4.002 · 1.10.2.002		

LO QUE TE PREGUNTAN

- El toxíndrome simpaticomimético (cocaína, pasta base) se caracteriza por taquicardia, hipertensión severa, hipertermia, diaforesis y midriasis bilateral.
- En el dolor torácico inducido por cocaína, los betabloqueadores puros (Propranolol, Atenolol) están FORMALMENTE CONTRAINDICADOS por estimulación alfa sin oposición.
- El tratamiento de primera línea de la isquemia y dolor torácico por cocaína son las BENZODIACEPINAS ENDOVENOSAS asociadas a nitratos.
- El Flumazenil está contraindicado en la sobredosis de benzodiacepinas en pacientes con consumo crónico por el riesgo letal de desencadenar status epiléptico.

ALGORITMO · INTOXICACIÓN POR SUSTANCIAS: DEL TOXÍNDROME A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

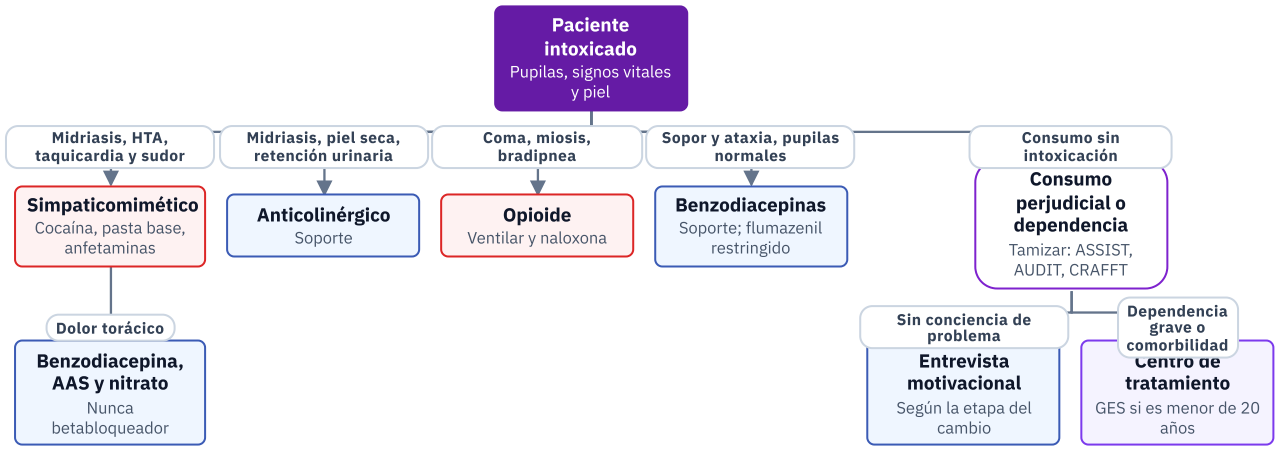


TABLA 17.16 · TOXÍNDROMES MAYORES EN EL SERVICIO DE URGENCIAS: RECONOCIMIENTO CLÍNICO RÁPIDO

TOXÍNDROME	DROGAS TÍPICAS	SIGNOS VITALES Y PUPILAS	MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y ANTÍDOTO
Simpaticomimético	Cocaína, pasta base, anfetaminas, éxtasis	Taquicardia, HTA severa, hipertermia, MIDRIASIS	Diaforesis, agitación, vasoespasmo · Antídoto: BENZODIACEPINAS EV
Sedante-Hipnótico	Benzodiacepinas, barbitúricos, zolpidem	Hipotensión leve, bradipnea, pupilas normales	Sopor, ataxia, disartria · Soporte ventilatorio (Flumazenil restringido)
Opioide	Morfina, heroína, fentanilo, metadona	BRADIPNEA SEVERA, hipotensión, MIOSIS PUNTIFORME	Coma, depresión respiratoria mortal · Antídoto: NALOXONA EV
Anticolinérgico	Atropina, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos	Taquicardia, hipertermia, MIDRIASIS ARREACTIVA	Piel seca y roja ("rojo como betarraga, seco como hueso, loco como cabra")

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-16

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Dolor torácico tras cocaína	Benzodiacepina, aspirina, nitrato	Atenolol o propranolol

REGLA DE ORO **Pupila y signos vitales** — Midriasis simpática; miosis, opioide

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **1, 20, 74–77** (págs. 8, 11, 19–20) · solucionario págs. 22, 24, 34.

Clase 17.16 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.17 Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
7 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.016	Trastornos de la personalidad	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
5.01.3.010	Personalidad: Concepto y medición. Principales teorías en psicología de la personalidad	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- Los Trastornos de la Personalidad son patrones perdurables, rígidos y egosintónicos con debut en la adolescencia o adultez joven.
- **Clúster A**: Raros y excéntricos (Paranoide, Esquizoide, Esquizotípico).
- **Clúster B**: Dramáticos e impulsivos (Límite, Antisocial, Histriónico, Narcisista).
- **Clúster C**: Ansiosos y temerosos (Evitativo, Dependiente, Obsesivo-Compulsivo).

ALGORITMO · TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: DEL CUADRO AL CLÚSTER

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

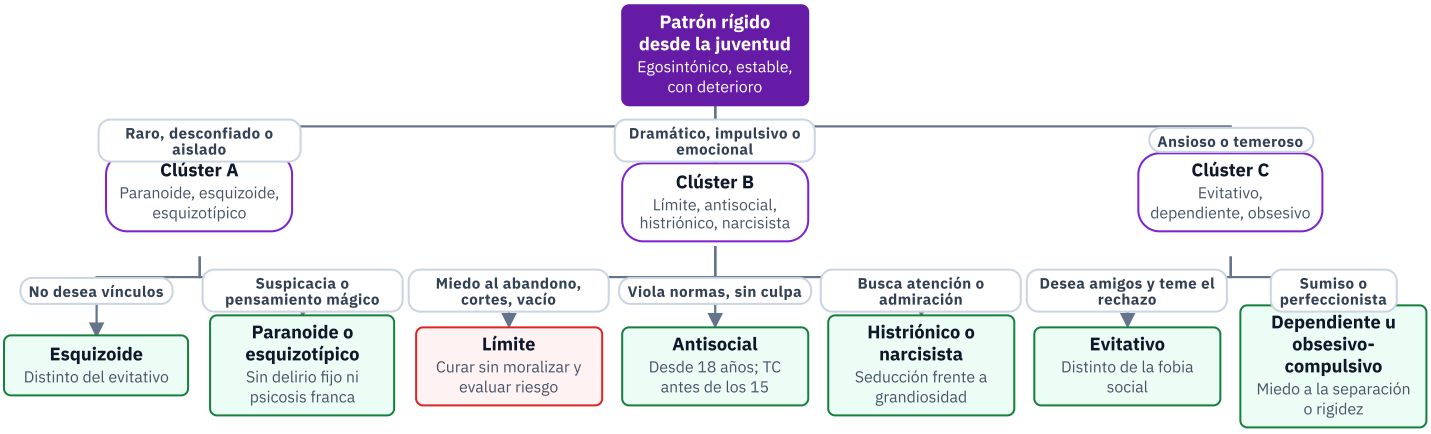


TABLA 17.17 · MATRIZ COMPARATIVA DE LOS 10 TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD SEGÚN DSM-5

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE PSIQ-17

CLÚSTER	TRASTORNO DE PERSONALIDAD	RASGO CARDINAL DISTINTIVO	DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL CLAVE
Clúster A (Raros)	Paranoide	Suspicacia constante, desconfianza, rencor	Trastorno delirante (en paranoide no hay delirio fijo)
Clúster A (Raros)	Esquizoide	Aislamiento voluntario, frialdad, desinterés social	Evitativo (en esquizoide NO hay deseo de socializar)
Clúster A (Raros)	Esquizotípico	Pensamiento mágico, excentricidad, rarezas	Esquizofrenia (en esquizotípico no hay psicosis franca)

REGLA DE ORO **A raros, B dramáticos, C ansiosos** — Patrón egosintónico desde joven

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **78–85** (págs. 20–21) · solucionario págs. 34–35.

Clase 17.17 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

★★★ PRIORIDAD ALTA
19 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.028	Trastorno por déficit atencional	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Completo
5.01.1.018	Trastornos de la conducta alimentaria	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
5.01.1.023	Trastorno del espectro autista	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
5.01.1.024	Trastorno específico del aprendizaje escolar	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar
5.01.1.025	Retardo mental	Dx Sospecha	Tx Inicial	Seg Derivar

+ 9 códigos relacionados: 5.01.1.026 · 5.01.1.030 · 5.01.1.031 · 5.01.1.033 · 5.01.4.004 · 2.01.1.082 · 2.01.1.085 · 2.01.1.139 · 2.01.1.142

LO QUE TE PREGUNTAN

- El TDAH exige que varios síntomas de inatención o hiperactividad estén presentes antes de los **12 años** y se manifiesten en al menos 2 entornos distintos (colegio y hogar).
- El Metilfenidato es el tratamiento farmacológico de primera elección en el TDAH en edad escolar.
- En la Anorexia Nervosa el peso corporal es significativamente bajo (IMC < 18.5) con miedo intenso a engordar y distorsión de la silueta corporal.
- **Criterios de hospitalización inmediata en anorexia**: IMC < **13-14 kg**/m², bradicardia < **40 lpm**, hipotensión < 80/**50 mmHg**, QTc > 460 ms e hipokalemia.
- En la Bulimia Nervosa existen atracones seguidos de purgas compensatorias, pero el peso corporal es habitualmente normal o en sobrepeso.

ALGORITMO · ADOLESCENTE CON ALTERACIÓN DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.18 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: ANOREXIA NERVOSA VS BULIMIA NERVOSA VS TRASTORNO POR ATRACÓN

CARACTERÍSTICA CLÍNICA	ANOREXIA NERVOSA	BULIMIA NERVOSA	TRASTORNO POR ATRACÓN (BINGE EATING)
Peso Corporal / IMC	SIGNIFICATIVAMENTE BAJO (IMC < 18.5; grave < 14)	HABITUALMENTE NORMAL O SOBREPESO	Sobrepeso u Obesidad marcada
Atracones compulsivos	Solo en subtipo purgativo (cantidades pequeñas)	SIEMPRE PRESENTES (grandes cantidades voraces)	SIEMPRE PRESENTES (con gran culpa posterior)
Conductas compensatorias	Restricción extrema, ejercicio extenuante, purgas	SIEMPRE PRESENTES (vómitos, laxantes, ayuno)	ESTRICTAMENTE AUSENTES (no hay purgas)
Distorsión de imagen	Severa (se ve gorda estando caquéctica)	Preocupación excesiva por el peso y la silueta	Malestar subjetivo pero sin distorsión dismórfica
Fármaco de elección	Ningún psicofármaco revierte la emaciación	Fluoxetina en dosis altas (60 mg/día) + TCC	Lisdexanfetamina o Topiramato + TCC

TRAMPAS EUNACOM

clase psiq-18

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
IMC 13,7, FC 36, QTc largo	Hospitalizar de inmediato	Manejo ambulatorio

REGLA DE ORO **TDAH: antes de 12 años y en 2 entornos** — Metilfenidato de primera línea

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **55, 86–90** (págs. 16, 21) · solucionario págs. 30, 36.

Clase 17.18 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL

17.20 Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

5.01.1.017	Disfunción sexual	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
5.01.1.019	Sexualidad humana y sus alteraciones	Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar	
5.01.3.012	Respuesta sexual humana	Conocimiento general	
5.01.3.006	Disforia de género	Conocimiento general	
3.01.3.014	Sexualidad, género y diversidad	Conocimiento general	

LO QUE TE PREGUNTAN

- Las fases de Masters y Johnson son excitación, meseta, orgasmo y resolución; el período refractario masculino ocurre en la resolución.
- **Disfunción sexual en el DSM-5**: **6 meses** o más, en **75-100%** de las ocasiones y con malestar significativo.
- Erecciones nocturnas o matinales conservadas orientan a causa psicógena; inicio gradual y generalizado, a causa orgánica o de fármacos.
- ISRS retrasan el orgasmo, los antipsicóticos reducen el deseo por hiperprolactinemia y los iPDE5 están contraindicados con nitratos.
- **Trastorno parafílico**: patrón de **6 meses** o más con malestar, deterioro o falta de consentimiento; exhibicionismo no es lo mismo que voyeurismo ni que frotteurismo.

ALGORITMO · QUEJA SEXUAL: DE LA DEFINICIÓN A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción



TABLA 17.20 · DISFUNCIONES SEXUALES DEL DSM-5: ENTIDAD Y MANEJO INICIAL

= TABLA DE TRAMPAS EUNACOM DE LA CLASE PSIQ-20

ENTIDAD	DEFINICIÓN CLAVE	MANEJO INICIAL
Trastorno eréctil	Dificultad para obtener o mantener la erección	Estudio de factores de riesgo vascular · iPDE5 (contraindicados con nitratos)
Eyaculación precoz	Eyaculación cerca de 1 minuto de la penetración, antes de lo deseado	Parada-inicio o compresión · ISRS o dapoxetina
Eyaculación retardada	Retardo o ausencia de eyaculación	Revisar fármacos (ISRS) · terapia sexual
Deseo hipoactivo (masculino) / interés y excitación (femenino)	Falta de deseo o de excitación	Buscar depresión, fármacos, hipogonadismo y problemas de pareja
Trastorno orgásmico femenino	Retardo o ausencia de orgasmo o intensidad muy reducida	Educación · focalización sensorial · terapia sexual
Dolor genitopélvico / penetración	Dolor, miedo o contracción de la musculatura pélvica en la penetración	Descartar causa orgánica · dilatadores y terapia · fisioterapia del piso pélvico

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

clase psiq-20

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Disfunción eréctil, HTA con enalapril	iPDE5 primera línea	Testosterona o consejería sola
Eyaculación en menos de 1 minuto	ISRS o dapoxetina y stop-start	Alprazolam o sildenafil
Idea intrusiva de ser pedófilo, la rechaza	TOC	Parafilia

REGLA DE ORO **Excitación, meseta, orgasmo, resolución** — Refractario masculino en la resolución

PRACTICA **Libro Gordo Psiquiatría General**, preguntas **19, 37** (págs. 11, 13) · solucionario págs. 24, 27.

Clase 17.20 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 20 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · TRASTORNOS DEL ÁNIMO & URGENCIAS SUICIDAS	
17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES	pág. 3
Fluoxetina **20 a 60 mg** al día — Vida media larga	DOSIS
Peso y apetito — Cambio mayor al **5%** en un mes	TIEMPO
Sertralina **50 a 200 mg** al día — Cardiopatía isquémica y lactancia	DOSIS
Prevalencia adulta cerca del **17%** — Mujer a hombre, 2 a 1	CORTE
17.2 Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES	pág. 5
Muestra a las **12 horas** — Después de la última dosis	DOSIS
Quetiapina **300 mg** al día — Lurasidona o cariprazina también	DOSIS
Profilaxis: **0,6 a 1,0 mEq/L** — Manía aguda: 0,8 a 1,2	CORTE
17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización	pág. 7
Mujeres: más intentos — **3 a 4 veces** más	CORTE
Hombres: más suicidios consumados — **4 a 5 veces** más	CORTE
17.4 Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal	pág. 8
Semana 2 a 6 — Hasta 1 año; afecta a **10 a 15%**	TIEMPO
1 a 2 por 1.000 partos — Primeras **1 a 2 semanas**	TIEMPO
Sertralina: primera elección — **50 a 100 mg**; casi no pasa a la leche	DOSIS
Día 3 a 5 del posparto — Afecta a **50 a 80%** de las madres	TIEMPO
17.5 Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo	pág. 9
2 años en adultos — 1 año en niños y adolescentes	CORTE
Somatización, hipocondría, dolor persistente — Somatización: varios sistemas, antes de los **30 años**	CORTE
BLOQUE 02 · TRASTORNOS DE ANSIEDAD, TOC & TRAUMA	
17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS	pág. 10
Antes de iniciar litio — Y luego cada **6 a 12 meses**	TIEMPO
El litio da hipotiroidismo y bocio — Hasta **20 %**; se agrega levotiroxina, sin suspender	CORTE
17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social	pág. 11
Venlafaxina como alternativa — **75 a 150 mg** al día	DOSIS
Pasadas **4 a 8 semanas** — Tolerancia, dependencia, memoria	TIEMPO
La más frecuente: **7 a 9 %** de la población — Inicio en la infancia	CORTE
17.8 Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS	pág. 12
Más de **1 hora** al día — O malestar y deterioro significativos	TIEMPO
17.9 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo	pág. 13
Prazosina al acostarse — **1 a 5 mg**, dosis baja al inicio	DOSIS
De **3 días** a **1 mes** — Si pasa de un mes: TEPT	TIEMPO
BLOQUE 03 · TRASTORNOS PSICÓTICOS & URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS	
17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES	pág. 14
Olanzapina **10 a 20 mg** — Sedante; alerta metabólica	DOSIS
Risperidona **2 a 6 mg** — Sobre **6 mg**: más SEP y prolactina	DOSIS
Aripiprazol **10 a 30 mg** — Agonista parcial D2; no engorda	DOSIS
Quetiapina **300 a 800 mg** — Sedante; casi sin efectos motores	DOSIS

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma	pág. 16
El más eficaz de todos — **100 a 400 mg** al día	DOSIS
Convulsiones: sobre **600 mg** — Bajar dosis y agregar valproato	DOSIS
Agranulocitosis en cerca de **0,8%** — Potencialmente mortal	CORTE
Desde el año: mensual — Mientras la tome y **4 semanas** después	TIEMPO
17.12 Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve	pág. 17
Dura de **1 a 6 meses** — Si pasa de **6 meses**: esquizofrenia	TIEMPO
17.13 Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo	pág. 18
Acidosis metabólica láctica — pH < 7,25 en los graves	DOSIS
CPK > 1.000, a menudo > 10.000 — Puede llegar a **50.000 UI**/L	DOSIS
17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada	pág. 20
Quetiapina **25 mg** VO — Alternativa atípica	DOSIS
Haloperidol **0,5 a 1 mg** VO o IM — Solo si hay riesgo	DOSIS
17.19 Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense	pág. 21
Adulto: **7 a 9 horas** — Ciclos de unos **90 minutos** NREM y REM	TIEMPO
Cafeína, tabaco y alcohol de noche — Cafeína **6 a 8 horas** antes	TIEMPO
BLOQUE 04 · ADICCIONES, PERSONALIDAD & SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL	
17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke	pág. 22
Lorazepam: sin metabolitos activos — **2 a 4 mg** VO o SL cada **2 h**	DOSIS
Mortalidad de **5 a 15 %** sin tratamiento — Hospitalizar	CORTE
Profilaxis: **100 a 250 mg** al día IM o EV — Todo alcohólico hospitalizado	DOSIS
17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)	pág. 24
Benzodiacepinas EV — Diazepam **5-10 mg** o lorazepam **2-4 mg**	DOSIS
Aspirina y nitroglicerina — AAS **250 mg**; nitrato sublingual	DOSIS
Coma, miosis y depresión respiratoria — Naloxona **0,4-2 mg** IV, IM o intranasal	DOSIS
17.17 Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C	pág. 25
Antisocial: viola los derechos ajenos — Sin remordimiento, desde los **15 años**	CORTE
Esquizoide no desea; evitativo sí desea — Antisocial: **18 años** y TC antes de los 15	CORTE
17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria	pág. 26
K < 3, hipofosfatemia, hipoglicemia — Trastornos metabólicos	META
Bradicardia, hipotensión, hipotermia — FC < **50 lpm**	CORTE
FC < 40, PAS < 80, QTc > 460 — Arritmias ventriculares	CORTE
CI < 70 y déficit adaptativo — Inicio en el desarrollo	CORTE
17.20 Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad	pág. 27
6 meses o más — Duración mínima	TIEMPO
En el **75 a 100 %** de las ocasiones — Casi siempre	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES			pág. 3
Mantenimiento · Derivar si recae en tratamiento	**O falla a dos antidepresivos, psicosis, riesgo**		
17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS			pág. 10
Implicancias · Corregir la tiroides suele resolver el síntoma	**Betabloqueador para temblor y ansiedad**		
Implicancias · El litio da hipotiroidismo y bocio	**Hasta 20 %; se agrega levotiroxina, sin suspender**		
17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social			pág. 11
Fobia específica · Primera línea	**Solo puntual: benzodiacepina o betabloqueador**		
17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES			pág. 14
Antipsicóticos de segunda generación · Otros dos	**Aripiprazol 10 a 30 mg**	Agonista parcial D2; no engorda	
17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma			pág. 16
¿Cuándo es refractaria? · Qué se hace	**Clozapina: elección indiscutida**	Nivel secundario y farmacovigilancia	
17.12 Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve			pág. 17
Fármacos y seguridad · Antipsicótico atípico	**Aripiprazol o risperidona**		
17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada			pág. 20
Contención farmacológica · Si rechaza: intramuscular	**Alternativa: olanzapina o aripiprazol IM**	Olanzapina **10 mg**; aripiprazol **9,75 mg**	
17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke			pág. 22
Fármacos para mantener la abstinencia · Naltrexona 50 mg al día	**Reduce el craving; no con opioides ni hepatitis**		
17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)			pág. 24
Benzodiacepina sí, betabloqueador no · Qué se hace	**Aspirina y nitroglicerina**	AAS **250 mg**; nitrato sublingual	
17.20 Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad			pág. 27
Fármacos que lo causan	**Antipsicóticos, betabloqueadores, tiazidas**	Y espironolactona	

GES de Psiquiatría y Salud Mental

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 21): Depresión en personas de 15 años y más · Sospecha con confirmación diagnóstica en ≤ 24 horas en Atención Primaria de Salud (APS), inicio inmediato de psicoterapia y farmacoterapia (ISRS de 1.ª línea), y control clínico presencial a las 2 semanas.**

Tema **17.1** · Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES
`5.01.1.007` · `5.01.1.008` · `5.01.1.034`
pág. 3

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 52): Trastorno Bipolar en personas de 15 años y más · Confirmación diagnóstica por médico especialista en psiquiatría en ≤ 60 días desde la sospecha, inicio inmediato de tratamiento farmacológico estabilizador del ánimo y hospitalización de urgencia protegida en episodio maníaco agudo.**

Tema **17.2** · Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES
`5.01.1.009` · `5.01.4.003`
pág. 5

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 21): Depresión en personas de 15 años y más · Tamizaje universal obligatorio con Escala de Edimburgo (EPDS) en controles de niño sano a los 2 y 6 meses en APS · Manejo con psicoterapia y fármacos compatibles con la lactancia.**

Tema **17.4** · Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal
`5.01.1.007`
pág. 8

GES **GES N° 21 en caso de sobreimposición de episodio depresivo mayor ("depresión doble") · Manejo en APS con psicoterapia de apoyo y resolución de estresores psicosociales.**

Tema **17.5** · Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo
`5.01.1.004` · `5.01.1.020`
pág. 9

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 34): Primer Episodio de Esquizofrenia en personas de 15 años y más · Sospecha con confirmación diagnóstica en ≤ 20 días por médico psiquiatra, e inicio de tratamiento farmacológico y psicosocial integral en ≤ 24 horas desde la confirmación.**

Tema **17.10** · Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES
`5.01.1.010` · `5.01.5.002`
pág. 14

GES **Garantía Explícita en Salud (GES N° 34): Canasta de Esquizofrenia Refractaria · Programa Nacional de Farmacovigilancia de Clozapina con monitoreo hematológico obligatorio.**

Tema **17.11** · Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma
`5.01.1.010` · `1.08.4.008`
pág. 16

GES **Norma Técnica de Salud Mental MINSAL · Sin cobertura GES directa para trastorno delirante crónico no esquizofrénico · Derivación a COSAM.**

Tema **17.12** · Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve
`5.01.1.010`
pág. 17

GES **Garantía GES Consumo Perjudicial o Dependencia de Alcohol y Drogas en personas menores de 20 años · Programa Nacional de Detección e Intervención Breve del Alcoholismo MINSAL en APS.**

Tema **17.15** · Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke
`5.01.1.012` · `1.10.2.004` · `1.10.3.001`
pág. 22

GES **Garantía GES Consumo de Drogas en menores de 20 años · Programa Nacional SENDA / MINSAL.**

Tema **17.16** · Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)
`5.01.2.003` · `5.01.1.013` · `5.01.1.011`
pág. 24

Sin garantía GES específica (11 temas): 17.3 · 17.6 · 17.7 · 17.8 · 17.9 · 17.13 · 17.14 · 17.19 · 17.17 · 17.18 · 17.20. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

4 temas · ★★★

- ★★★ **17.11** Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma 16
- ★★★ **17.10** Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES 14
- ★★★ **17.12** Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve 17
- ★★★ **17.1** Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES 3

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 3–17, 38–46, 56–57.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **17.6** Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS 10
- ★★★ **17.4** Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal 8
- ★★★ **17.5** Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo 9
- ★★★ **17.18** Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria 26

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 21–29, 55, 86–90.

DÍA 3

3 temas · ★★

- ★★☆ **17.9** Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo 13
- ★★☆ **17.16** Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) 24
- ★★☆ **17.2** Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES 5

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 1, 18, 20, 47–54, 74–77.

DÍA 4

3 temas · ★★

- ★★☆ **17.7** Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social 11
- ★★☆ **17.15** Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke 22
- ★★☆ **17.8** Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS 12

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 30–36, 67–72.

DÍA 5

3 temas · ★

- ★☆☆ **17.14** Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada 20
- ★☆☆ **17.19** Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense 21
- ★☆☆ **17.17** Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C 25

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 62–66, 78–85.

DÍA 6

3 temas · ★

- ★☆☆ **17.13** Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo 18
- ★☆☆ **17.3** Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización 7
- ★☆☆ **17.20** Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad 27

Practica: Libro Gordo Psiquiatría General, preguntas 2, 19, 37, 58–61.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 28
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 17.1 · 17.4 · 17.5 · 17.6 · 17.10 · 17.11 · 17.12 · 17.18
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Psiquiatría General en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 8 temas

35 17.11. Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma GES 16
34 17.10. Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES GES 14
34 17.12. Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve GES 17
25 17.1. Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES GES 3
20 17.6. Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS 10
19 17.4. Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal GES 8
19 17.5. Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo GES 9
19 17.18. Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria 26

★★ Prioridad media · 6 temas

16 17.9. Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo 13
13 17.16. Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas) GES 24
12 17.2. Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES GES 5
12 17.7. Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social 11
12 17.15. Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke GES 22
11 17.8. Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS 12

★ Prioridad baja · 6 temas

8 17.14. Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada 20
8 17.19. Psiquiatría General: Clasificaciones (DSM-5/CIE-10), Higiene del Sueño, Trastornos Facticios y Nociones de Psiquiatría Forense 21
7 17.17. Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C 25
5 17.13. Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo 18
2 17.3. Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización 7
2 17.20. Sexualidad Humana: Respuesta Sexual, Disfunciones Sexuales, Parafilias, Disforia de Género y Diversidad 27